# KHẢO SÁT SỨC KHỎE TÂM THẦN VỊ THÀNH NIÊN VIỆT NAM (V-NAMHS)

## BÁO CÁO VỀ CÁC KẾT QUẢ CHÍNH

THÁNG 11 NĂM 2022

### Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam (V-NAMHS)

**Báo cáo về Các Kết quả Chính**

Vũ Mạnh Lợi, Nguyễn Đức Vinh (Viện Xã hội học)

Đào Thị Khánh Hòa (Hội Xã hội học Việt Nam)

Holly E. Erskine, Cartiah McGrath, Krystina Wallis, Sarah J. Blondell,

Harvey A. Whiteford, James G. Scott (Đại học Queensland)

Robert Blum, Shoshanna Fine, Mengmeng Li, Astha Ramaiya,

(Trường Y tế Công cộng Bloomberg, Đại học Johns Hopkins)

**Trích dẫn đề xuất:**

Institute of Sociology, University of Queensland, and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

2022. Viet Nam Adolescent Mental Health Survey: Report on Main Findings. Ha noi, Viet Nam: Institute of

Sociology.

## Mục lục

| Nội dung | Trang |

|---|---|

| Danh sách Bảng biểu | 3 |

| Danh sách Hình | 4 |

| Từ viết tắt | 5 |

| Lời cảm ơn | 6 |

| Tóm tắt Tổng quan | 7 |

| GIỚI THIỆU | 9 |

| Bối cảnh | 9 |

| V-NAMHS là gì? | 10 |

| Ai thực hiện V-NAMHS? | 10 |

| Ai tham gia V-NAMHS? | 10 |

| Người tham gia được hỏi những gì? | 12 |

| V-NAMHS được thực hiện khi nào? | 12 |

| COVID-19 có ảnh hưởng đến V-NAMHS không? | 12 |

| Phạm vi của báo cáo này là gì? | 12 |

| ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT | 14 |

| Vị thành niên | 14 |

| Phụ huynh | 15 |

| SỨC KHỎE TÂM THẦN | 17 |

| Tổng quan | 17 |

| Đo lường | 18 |

| Công cụ đo lường | 18 |

| Vấn đề sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần (Mental health problems and mental disorders) | 18 |

| Vấn đề sức khỏe tâm thần (Mental health problems) | 20 |

| Rối loạn tâm thần (Mental disorders) | 21 |

| Hành vi tự tử và tự gây thương tích (Suicidal behaviours and self-harm) | 22 |

| Các cân nhắc | 23 |

| Diễn giải | 23 |

| Hạn chế | 23 |

| Hàm ý | 24 |

| SỬ DỤNG DỊCH VỤ | 25 |

| Tổng quan | 25 |

| Đo lường | 26 |

| Kết quả | 26 |

| Tần suất và loại hình sử dụng dịch vụ | 26 |

| Nhu cầu nhận thức được và rào cản tiếp cận chăm sóc (Perceived need and barriers to care) | 27 |

| Hỗ trợ không chính thức (Informal support) | 28 |

| Chiến lược tự giúp đỡ (Self-help strategies) | 28 |

| Các cân nhắc | 29 |

| Diễn giải | 29 |

| Hạn chế | 30 |

| Hàm ý | 30 |

| COVID-19 | 32 |

| Tổng quan | 32 |

| Đo lường | 33 |

| Kết quả | 33 |

| Các cân nhắc | 34 |

| Diễn giải | 34 |

| Hạn chế | 34 |

| Hàm ý | 35 |

| Phụ lục 1: Công cụ đo lường | 36 |

| Phụ lục 2: Phương pháp nghiên cứu | 38 |

| Phụ lục 3: Bảng thuật ngữ | 41 |

| Phụ lục 4: Nhóm nghiên cứu | 44 |

| TÀI LIỆU THAM KHẢO | 45 |

## Danh sách Bảng biểu

| Bảng | Nội dung | Trang |

|---|---|---|

| Bảng 1 | Tuyển chọn mẫu cho V-NAMHS | 11 |

| Bảng 2 | Mẫu vị thành niên theo giới tính và nhóm tuổi | 14 |

| Bảng 3 | Mẫu vị thành niên theo tình trạng học vấn và việc làm | 15 |

| Bảng 4 | Mẫu người chăm sóc chính theo thông tin nhân khẩu học | 15 |

| Bảng 5 | Định nghĩa về vấn đề sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần | 19 |

| Bảng 6 | Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ 10-17 tuổi theo giới tính và nhóm tuổi | 20 |

| Bảng 7 | Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ 10-17 tuổi có suy giảm chức năng theo lĩnh vực suy giảm (impairment domain) | 21 |

| Bảng 8 | Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của các rối loạn tâm thần ở trẻ 10-17 tuổi theo loại | 22 |

| Bảng 9 | Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của các rối loạn tâm thần ở trẻ 10-17 tuổi theo lĩnh vực suy giảm | 22 |

| Bảng 10 | Hành vi tự tử ở trẻ 10-17 tuổi | 22 |

| Bảng 11 | Tự gây thương tích ở trẻ 10-17 tuổi | 22 |

| Bảng 12 | Tần suất tiếp cận dịch vụ hỗ trợ hoặc tư vấn cho các vấn đề cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua ở trẻ 10-17 tuổi theo giới tính | 26 |

| Bảng 13 | Nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng nhiều nhất cho các vấn đề cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua ở trẻ 10-17 tuổi | 27 |

| Bảng 14 | Rào cản trong việc tìm kiếm hoặc nhận hỗ trợ cho các vấn đề cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua ở phụ huynh của trẻ 10-17 tuổi | 28 |

| Bảng 15 | Người được nói chuyện khi có lo lắng hoặc quan ngại ở trẻ 10-17 tuổi | 28 |

| Bảng 16 | Chiến lược tự giúp đỡ được sử dụng để quản lý hoặc phòng ngừa các vấn đề cảm xúc và hành vi ở trẻ 10-17 tuổi | 29 |

| Bảng 17 | Tỷ lệ thường xuyên gặp các vấn đề cảm xúc và hành vi nhiều hơn bình thường trong đại dịch COVID-19 ở trẻ 10-17 tuổi theo giới tính | 33 |

| Bảng 18 | Dân số Việt Nam năm 2019 theo vùng và khu vực nông thôn-thành thị | 38 |

## Danh sách Hình

| Hình | Nội dung | Trang |

|---|---|---|

| Hình 1 | Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ 10-17 tuổi theo loại | 20 |

| Hình 2 | Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của các vấn đề sức khỏe tâm thần theo ngưỡng triệu chứng (symptom threshold) và xác nhận suy giảm chức năng (impairment endorsement) ở trẻ 10-17 tuổi | 21 |

| Hình 3 | Ngưỡng triệu chứng và xác nhận suy giảm chức năng ở trẻ 10-17 tuổi có vấn đề sức khỏe tâm thần sử dụng dịch vụ trong 12 tháng qua | 27 |

| Hình 4 | Trải nghiệm trong đại dịch COVID-19 ở trẻ 10-17 tuổi | 34 |

| Hình 5 | Bản đồ Việt Nam và 48 tỉnh/thành phố được chọn | 39 |

## Từ viết tắt

| Viết tắt | Nghĩa đầy đủ |

|---|---|

| ADHD | Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder) |

| CBCL | Bảng kiểm Hành vi Trẻ em (Child Behaviour Checklist) |

| DISC-5 | Bảng Phỏng vấn Chẩn đoán cho Trẻ em, Phiên bản 5 (Diagnostic Interview Schedule for Children, Version 5) |

| DSM-5 | Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê các Rối loạn Tâm thần, Ấn bản thứ 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition) |

| EA | Khu vực điều tra (Enumeration Area) |

| GBD | Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu (Global Burden of Disease Study) |

| GEAS | Nghiên cứu Vị thành niên Sớm Toàn cầu (Global Early Adolescent Study) |

| GOPFP | Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình, Việt Nam (General Office for Population and Family Planning) |

| GSHS | Khảo sát Sức khỏe Học sinh Toàn cầu dựa trên Trường học (Global School-based Student Health Survey) |

| GSO | Tổng cục Thống kê Việt Nam (General Statistical Office of Viet Nam) |

| HSPI | Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Health Strategy and Policy Institute) |

| HICs | Các quốc gia thu nhập cao (High-income countries) |

| HREC | Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu trên Người (Human Research Ethics Committee) |

| I-NAMHS | Indonesia – Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Quốc gia (Indonesia – National Adolescent Mental Health Survey) |

| IOS | Viện Xã hội học (Institute of Sociology) |

| JHSPH | Trường Y tế Công cộng Bloomberg, Đại học Johns Hopkins (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) |

| K-NAMHS | Kenya – Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Quốc gia (Kenya – National Adolescent Mental Health Survey) |

| LMICs | Các quốc gia thu nhập thấp và trung bình (Low- and middle-income countries) |

| MOH | Bộ Y tế (Ministry of Health) |

| NAMHS | Các Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Quốc gia (National Adolescent Mental Health Surveys) |

| POPFP | Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình cấp tỉnh (Provincial Office of Population and Family Planning) |

| PTSD | Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder) |

| SDQ | Bảng hỏi Điểm mạnh và Khó khăn (Strengths and Difficulties Questionnaire) |

| SESD | Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường (Social-Environmental Statistics Department) |

| TUQIA | Đại học Queensland tại Hoa Kỳ (The University of Queensland in America) |

| UQ | Đại học Queensland (The University of Queensland) |

| VASS | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viet Nam Academy of Social Sciences) |

| V-NAMHS | Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam (Viet Nam Adolescent Mental Health Survey) |

| WHO | Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) |

| YSR | Bản Tự báo cáo của Thanh thiếu niên (Youth Self-Report) |

## Lời cảm ơn

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo sư Đặng Nguyên Anh (Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam từ năm 2016 đến 2021) vì đã hỗ trợ Viện Xã hội học (IOS) tham gia dự án quốc tế Các Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Quốc gia (NAMHS), vì những lời khuyên quý báu trong giai đoạn đầu của Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam (V-NAMHS) và sự tham gia liên tục với tư cách là thành viên nghiên cứu của V-NAMHS.

Trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện V-NAMHS, cũng như trong quá trình xử lý và phân tích dữ liệu, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ, tư vấn và khuyến khích liên tục từ các nhóm quốc tế phụ trách Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Quốc gia Kenya (K-NAMHS) và Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Quốc gia Indonesia (I-NAMHS). Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tiến sĩ Caroline Kabiru, Tiến sĩ Yohannes Dibaba Wado, Tiến sĩ Frederick Murunga Wekesah, Sally Odunga, Vivian Nyakangi, và Anne Njeri từ nhóm K-NAMHS, và Giáo sư Siswanto Wilopo, Tiến sĩ Amirah Ellyza Wahdi, Rizka Rachmawati, Althaf Setyawan, và Yufan Putri Astrini từ nhóm I-NAMHS. Ngoài ra, chúng tôi xin ghi nhận công việc của nhóm NAMHS tại Trường Y tế Công cộng Bloomberg, Đại học Johns Hopkins (JHSPH) vì sự hỗ trợ lập trình và phân tích dữ liệu, đặc biệt là sự hỗ trợ lập trình khảo sát của Mark Emerson. Chúng tôi cũng muốn ghi nhận những đóng góp của Meaghan Enright và Jamileh Shadid từ Đại học Queensland (UQ) vì sự hỗ trợ trong quá trình thực hiện V-NAMHS bao gồm đào tạo cho nghiên cứu thí điểm (pilot study), thử nghiệm các công cụ thu thập dữ liệu, lập trình và các công việc khác liên quan đến khảo sát.

Chúng tôi cũng xin ghi nhận Prudence Fisher, tác giả của Bảng Phỏng vấn Chẩn đoán cho Trẻ em, Phiên bản 5 (DISC-5), người đã hào phóng cung cấp công cụ này và hỗ trợ việc chuyển thể và triển khai.

Một số chuyên gia tại Việt Nam đã đóng góp chuyên môn của họ cho việc thực hiện V-NAMHS. Chúng tôi xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Chung (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Tổng cục Thống kê Việt Nam [GSO]) vì đóng góp của ông cho phương pháp lấy mẫu được sử dụng trong V-NAMHS. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Tiến sĩ Trần Thị Mai Oanh (Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế [HSPI], Bộ Y tế [MOH]) và Tiến sĩ Hoàng Thị Phương (Phó Trưởng khoa Kinh tế Y tế, HSPI, MOH) vì những đóng góp của họ cho nghiên cứu thí điểm và trong giai đoạn đầu của V-NAMHS.

Chúng tôi cảm ơn ông Nguyễn Doãn Tú (Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình [GOPFP], MOH) và Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng (Phó Tổng cục trưởng, GOPFP, MOH) vì sự hợp tác hiệu quả giữa GOPFP và IOS trong việc thu thập dữ liệu đầu vào cho lấy mẫu cũng như trong việc tổ chức công tác thực địa của V-NAMHS. Chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình cấp tỉnh (POPFP) tại 38 tỉnh được đưa vào V-NAMHS và lãnh đạo cộng đồng/người gác cổng (gatekeepers) của tất cả các khu vực điều tra (EAs) vì sự hợp tác và hỗ trợ trong quá trình thực địa của V-NAMHS. Chúng tôi muốn cảm ơn nhân viên của các POPFP đã đảm nhận vai trò phỏng vấn viên cho V-NAMHS vì sự làm việc chăm chỉ trong quá trình thu thập dữ liệu.

Quan trọng nhất, chúng tôi cảm ơn các vị thành niên và phụ huynh của họ vì sự tham gia tự nguyện và hợp tác. Nếu không có sự tham gia và hỗ trợ của họ, V-NAMHS đã không thể thực hiện được.

NAMHS được tài trợ bởi Đại học Queensland tại Hoa Kỳ (TUQIA) thông qua sự hỗ trợ từ Pivotal Ventures, một công ty của Melinda French Gates. Kinh phí cho NAMHS được quản lý bởi UQ, và UQ đã cung cấp kinh phí cho V-NAMHS cho IOS, Việt Nam.

## Tóm tắt Tổng quan

### Tổng quan

Tỷ lệ hiện mắc (prevalence) của các rối loạn tâm thần (mental disorders) ở vị thành niên tại Việt Nam phần lớn chưa được biết đến. Dữ liệu tỷ lệ hiện mắc chính xác rất quan trọng cho công tác phòng ngừa hiệu quả, lập kế hoạch dịch vụ và ưu tiên chính sách sức khỏe tâm thần. Các ước tính chính xác cũng cho phép vận động dựa trên bằng chứng (evidence-based advocacy) và các chiến dịch y tế công cộng có thể nâng cao nhận thức và giảm kỳ thị (stigma) liên quan đến sức khỏe

tâm thần. Báo cáo này trình bày các kết quả từ Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam (V-NAMHS), khảo sát đầu tiên đo lường tỷ lệ hiện mắc các rối loạn tâm thần trên một mẫu đại diện quốc gia (nationally representative sample) của các hộ gia đình trên toàn Việt Nam.

Báo cáo này bao gồm các kết quả liên quan đến sức khỏe tâm thần, bao gồm cả các vấn đề sức khỏe tâm thần (mental health problems) và rối loạn tâm thần (mental disorders). Trong V-NAMHS, vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần là những người đáp ứng ít nhất một nửa số triệu chứng cần thiết cho một rối loạn tâm thần nhất định nhưng có thể không nhất thiết đáp ứng tất cả các tiêu chí chẩn đoán cần thiết cho chẩn đoán rối loạn tâm thần. Vị thành niên có rối loạn tâm thần là những người đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chẩn đoán cho một rối loạn tâm thần. Báo cáo này cũng bao gồm các kết quả liên quan đến việc sử dụng dịch vụ cho các vấn đề cảm xúc và hành vi (emotional and behavioural problems). Thay vì đề cập trực tiếp đến sức khỏe tâm thần, thuật ngữ "các vấn đề cảm xúc và hành vi" được sử dụng trong các câu hỏi liên quan đến sử dụng dịch vụ để tính đến vô số cách mà triệu chứng rối loạn tâm thần có thể biểu hiện và để tránh các vấn đề về kỳ thị hoặc hiểu biết kém về sức khỏe tâm thần (mental health literacy). Một chương về các kết quả liên quan đến COVID-19 trong bối cảnh sức khỏe tâm thần và hạnh phúc (wellbeing) cũng được cung cấp.

**Các kết quả chính**

- Trong 12 tháng qua, cứ năm vị thành niên Việt Nam thì có một người (21.7%) có vấn đề sức khỏe tâm thần trong khi cứ ba mươi người thì có một người đáp ứng tiêu chí cho rối loạn tâm thần (3.3%).

- Lo âu (anxiety) là vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất (18.6%), tiếp theo là trầm cảm (depression) (4.3%).

- Chỉ có 8.4% vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần đã tiếp cận các dịch vụ cung cấp hỗ trợ hoặc tư vấn cho các vấn đề cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua.

- Nhìn chung, chỉ có 6.5% vị thành niên tiếp cận dịch vụ như vậy trong 12 tháng qua và hơn một nửa (50.8%) chỉ sử dụng một lần.

- Chỉ có 5.1% phụ huynh xác định rằng con vị thành niên của họ cần giúp đỡ cho các vấn đề cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua, mặc dù 21.7% vị thành niên đã trải qua vấn đề sức khỏe tâm thần trong cùng kỳ.

- Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của vị thành niên, với 7.7% vị thành niên báo cáo thường xuyên trải qua ít nhất một vấn đề cảm xúc hoặc hành vi nhiều hơn bình thường trong đại dịch COVID-19.

**Hàm ý**

- Tỷ lệ hiện mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần ở vị thành niên tại Việt Nam cho thấy sức khỏe tâm thần là một vấn đề y tế công cộng đòi hỏi sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách và các nhà quy hoạch. Để giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần ở vị thành niên tại Việt Nam, các Kế hoạch Sức khỏe Tâm thần Quốc gia trong tương lai cần xem xét các nhu cầu cụ thể của vị thành niên bên cạnh các kế hoạch rộng hơn dành cho người lớn.

- Mặc dù cứ năm vị thành niên thì có một người trải qua vấn đề sức khỏe tâm thần và cứ ba mươi người thì có một người đáp ứng tiêu chí cho rối loạn tâm thần, những con số này có khả năng khả thi để giải quyết thông qua hành động và đầu tư phù hợp từ các nhà hoạch định chính sách.

- Phụ huynh và gia đình là nguồn hỗ trợ có khả năng nhất cho vị thành niên khi có lo lắng và quan ngại. Các chiến lược được thiết kế để cải thiện hiểu biết về sức khỏe tâm thần (mental health literacy), giảm kỳ thị liên quan đến sức khỏe tâm thần, và nâng cao nhận thức về các dịch vụ sẵn có trong các gia đình có thể hỗ trợ vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần.

- Chỉ một thiểu số vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần nhận được dịch vụ (8.4%). Để hỗ trợ vị thành niên, điều quan trọng là sàng lọc sức khỏe tâm thần (mental health screening) được tích hợp vào các dịch vụ y tế tổng quát hiện có đồng thời cung cấp giáo dục và đào tạo về sức khỏe tâm thần và các lộ trình chuyển tuyến (referral pathways) cho các nhân viên y tế tổng quát.

- Kết quả cho thấy 7.7% vị thành niên thường xuyên trải qua các vấn đề cảm xúc và hành vi nhiều hơn bình thường trong đại dịch COVID-19 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa sức khỏe tâm thần vào kế hoạch cho các sự kiện quy mô dân số trong tương lai như đại dịch, thiên tai và xung đột.

# GIỚI THIỆU

## Bối cảnh

Vị thành niên chiếm khoảng 14.5% dân số Việt Nam, tương đương gần 14 triệu người từ 10-19 tuổi (General Statistical Office 2020). Mặc dù thường được coi là giai đoạn khỏe mạnh của cuộc đời, rối loạn tâm thần là nguyên nhân hàng đầu gây khuyết tật (disability) ở vị thành niên trên toàn cầu (Erskine et al. 2015) và có thể gây ra các hậu quả về sức khỏe và xã hội cả ngắn hạn và dài hạn (Erskine et al. 2016, Ormel 2017). Hiểu được tỷ lệ hiện mắc của các rối loạn tâm thần, cũng như các yếu tố nguy cơ (risk factors) và yếu tố bảo vệ (protective factors) tiềm ẩn, là điều thiết yếu để cung cấp thông tin cho các chính sách sức khỏe tâm thần và lập kế hoạch nguồn lực hiệu quả cho sức khỏe tâm thần vị thành niên.

Cho đến nay, Việt Nam chưa có một chính sách sức khỏe tâm thần được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa là cung cấp "tầm nhìn, giá trị, nguyên tắc, mục tiêu và mô hình hành động rộng" (Trang Nguyen et al. 2019). Do đó, quản trị sức khỏe tâm thần bị phân mảnh và chỉ được các luật và quyết định hiện hành bao phủ một phần. Ví dụ, theo Luật Người khuyết tật (Luật số 51/2010/QH12), các cá nhân sống với khuyết tật tâm thần, tâm thần học và trí tuệ được xác định là một nhóm phụ theo Điều 3. Năm 2011, Quyết định 1215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hỗ trợ xã hội dựa vào cộng đồng cho người có rối loạn tâm thần (Thủ tướng Chính phủ 2011). Một năm sau, một đề án tổng thể được xây dựng cho Mạng lưới Cơ sở Bảo trợ Xã hội Chăm sóc và Phục hồi Chức năng Dựa vào Cộng đồng cho Người có Rối loạn Tâm thần (Quyết định 1364/QĐ-LĐTBXH do Bộ LĐTBXH ban hành) (MOLISA 2012). Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 155/QĐ-TTg (ngày 29 tháng 1 năm 2022) phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia Phòng chống Bệnh Không lây nhiễm và Rối loạn Sức khỏe Tâm thần giai đoạn 2022-2025". Trong Kế hoạch, rối loạn tâm thần đề cập đến "tâm thần phân liệt (schizophrenia), động kinh (epilepsy), trầm cảm (depression), sa sút trí tuệ (dementia) và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác" (Thủ tướng Chính phủ 2022). Các quyết định hiện hành này tập trung vào người lớn có bệnh tâm thần nặng và không đề cập cụ thể đến người trẻ. Trong lịch sử, chưa có một chính sách, chiến lược hoặc kế hoạch riêng biệt tập trung vào sức khỏe tâm thần vị thành niên tại Việt Nam và vị thành niên thay vào đó chỉ được đưa vào theo mặc định trong bất kỳ luật hoặc quyết định nào liên quan đến sức khỏe tâm thần. Việc thiếu các chính sách cụ thể cho sức khỏe

tâm thần ở vị thành niên khiến việc lập kế hoạch dịch vụ sức khỏe tâm thần dành riêng cho vị thành niên và các chiến lược y tế công cộng trở nên khó khăn.

Các nỗ lực cải thiện sức khỏe tâm thần vị thành niên tại Việt Nam bị cản trở thêm bởi sự thiếu bằng chứng về tỷ lệ hiện mắc các rối loạn tâm thần vị thành niên. Mặc dù các nghiên cứu có tồn tại, nghiên cứu hiện có về sức khỏe tâm thần vị thành niên tại Việt Nam bị hạn chế bởi phạm vi địa lý (ví dụ: chỉ Hà Nội), kích thước mẫu nhỏ, phạm vi tuổi hạn chế và việc sử dụng các thang đo triệu chứng (symptom measures) thay vì công cụ chẩn đoán (diagnostic instruments). Sự thiếu dữ liệu như vậy cho Việt Nam cản trở các nhà hoạch định chính sách, các nhà thực hành và các nhà nghiên cứu trong việc nhắm mục tiêu nỗ lực một cách phù hợp, phát triển kế hoạch dịch vụ hiệu quả, thu hút chính phủ các quốc gia vào hành động, và tăng sự chú ý và kinh phí cho sức khỏe tâm thần vị thành niên.

Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam (V-NAMHS) được phát triển và thực hiện với mục tiêu cụ thể là đưa ra các ước tính đại diện quốc gia về tỷ lệ hiện mắc các rối loạn tâm thần ở vị thành niên Việt Nam từ 10-17 tuổi. Các kết quả từ V-NAMHS cung cấp cho Chính phủ và các bên liên quan khác tại Việt Nam bằng chứng cần thiết để ưu tiên và lập kế hoạch dịch vụ cho sức khỏe tâm thần vị thành niên cũng như vận động cho việc phát triển các chính sách sức khỏe tâm thần vị thành niên. Cuối cùng, dữ liệu này cũng cung cấp các ước tính tỷ lệ hiện mắc cho các cơ quan quốc tế và các nỗ lực nghiên cứu toàn cầu, chẳng hạn như Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu (GBD) được các nhà hoạch định chính sách sử dụng để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định.

**V-NAMHS là gì?**

V-NAMHS là một khảo sát hộ gia đình đại diện quốc gia trên vị thành niên và người chăm sóc chính của họ. Các mục tiêu cốt lõi của V-NAMHS là:

1. Xác định tỷ lệ hiện mắc các rối loạn tâm thần ở vị thành niên từ 10-17 tuổi tại Việt Nam.

2. Đo lường các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ liên quan đến rối loạn tâm thần ở vị thành niên.

3. Thiết lập các mô hình sử dụng dịch vụ ở vị thành niên, bao gồm mức sử dụng, rào cản tiếp cận chăm sóc, và nhu cầu nhận thức được (perceived need).

**Ai thực hiện V-NAMHS?**

Viện Xã hội học (IOS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) chịu trách nhiệm thực hiện V-NAMHS. V-NAMHS là một phần của Các Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Quốc gia (NAMHS) được triển khai tại ba quốc gia (Kenya, Indonesia và Việt Nam) và do Đại học Queensland (UQ) tại Úc dẫn đầu với sự hỗ trợ từ Trường Y tế Công cộng Bloomberg, Đại học Johns Hopkins (JHSPH) tại Hoa Kỳ. Dự án được phát triển và triển khai một cách hợp tác. Các cộng tác viên khác của V-NAMHS bao gồm các chuyên gia từ Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (HSPI) thuộc Bộ Y tế (MOH), Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường (SESD) thuộc Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), và Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình (GOPFP) thuộc MOH.

Phê duyệt đạo đức cho nghiên cứu được lấy từ Hội đồng Đánh giá Đạo đức Thể chế cho Nghiên cứu Y sinh tại Đại học Y tế Công cộng Hà Nội (số phê duyệt 499/2019/YTCC-HD3) và Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu trên Người (HREC) của UQ (số phê duyệt 2019001268).

**Ai tham gia V-NAMHS?**

V-NAMHS là một khảo sát hộ gia đình đại diện quốc gia được thực hiện trên vị thành niên và người chăm sóc chính của họ tại 38 tỉnh ở Việt Nam. Vị thành niên đủ điều kiện là những người từ 10-17 tuổi sống với người chăm sóc chính hơn 50% thời gian. Vị thành niên từ 18-19 tuổi không thuộc phạm vi khảo sát vì tỷ lệ cao trong số những vị thành niên này có khả năng sống xa gia đình và vì các công cụ chẩn đoán không được thiết kế để áp dụng cho người từ 18 tuổi trở lên (Erskine et al. 2021). Trong các hộ gia đình có nhiều hơn một vị thành niên đủ điều kiện, một vị thành niên được chọn ngẫu nhiên từ danh sách hộ gia đình bằng công cụ thu thập dữ liệu được lập trình. Điều này đảm bảo không có sai lệch ngoài ý muốn (unintentional bias) trong việc lựa chọn vị thành niên tham chiếu.

Người chăm sóc chính được định nghĩa là một thành viên trưởng thành trong hộ gia đình (tức là từ 18 tuổi trở lên) có trách nhiệm và cung cấp sự chăm sóc cho vị thành niên, biết nhiều nhất về họ, và ở vị trí tốt nhất để trả lời các câu hỏi về sức khỏe và hạnh phúc của họ. Cho mục đích của báo cáo này, người chăm sóc chính sẽ được gọi là phụ huynh. Thông tin thêm về mối quan hệ giữa vị thành niên và người chăm sóc chính có trong phần Đặc điểm Mẫu Khảo sát.

Các hộ gia đình bị loại khỏi nghiên cứu nếu:

- Không có vị thành niên từ 10-17 tuổi sống tại địa chỉ được phỏng vấn

- Vị thành niên không sống tại địa chỉ được phỏng vấn phần lớn thời gian và/hoặc tạm thời vắng nhà

- Vị thành niên đã kết hôn

- Vị thành niên HOẶC phụ huynh không nói tiếng Việt

- Không có phụ huynh sống tại địa chỉ

- Hộ gia đình hoặc phụ huynh không đồng ý tham gia

- Vị thành niên không thể tham gia do suy giảm thể chất hoặc nhận thức nghiêm trọng (được đánh giá bằng thang đo tiêu chuẩn)

Như trình bày trong Bảng 1, tổng cộng 7,599 hộ gia đình từ 38 tỉnh trên toàn Việt Nam được chọn ngẫu nhiên để tiếp cận theo khung lấy mẫu khảo sát (xem Phụ lục 2: Phương pháp nghiên cứu). Trong số đó, 6,048 hộ gia đình đủ điều kiện và đồng ý tham gia, cho tổng tỷ lệ phản hồi (response rate) là 81.1% (được tính bằng cách chia tổng số hộ gia đình tham gia, đủ điều kiện [n = 6,048] cho tổng số hộ gia đình sau khi trừ các hộ không đủ điều kiện [n = 7,461]). Sự đồng ý có hiểu biết (informed consent) và sự chấp thuận (assent) được lấy từ phụ huynh và vị thành niên tương ứng. Phỏng vấn phụ huynh và vị thành niên được tiến hành riêng biệt và trong môi trường riêng tư để tránh sự can thiệp hoặc ảnh hưởng của người khác. Năm mươi hai hộ gia đình có dữ liệu không đầy đủ và không được đưa vào mẫu cuối cùng. Mẫu V-NAMHS cuối cùng bao gồm 5,996 cặp phụ huynh-vị thành niên.

**Bảng 1. Tuyển chọn mẫu cho V-NAMHS**

| Hạng mục | Số lượng |

|---|---|

| Tổng số hộ gia đình trong phạm vi tiếp cận | 7,599 |

| Tổng số hộ gia đình không được tiếp cận hoặc không có mặt | 502 |

| Tổng số hộ gia đình từ chối tham gia | 911 |

| Tổng số hộ gia đình không đủ điều kiện | 138 |

| Tổng số hộ gia đình tham gia, đủ điều kiện | 6,048 |

| Tổng số hộ gia đình có dữ liệu không đầy đủ | 52 |

| Tổng số hộ gia đình có dữ liệu đầy đủ | 5,996 |

**Người tham gia được hỏi những gì?**

Các rối loạn tâm thần được đánh giá bằng một công cụ chẩn đoán được thiết kế đặc biệt cho trẻ em và vị thành niên: Bảng Phỏng vấn Chẩn đoán cho Trẻ em, Phiên bản 5 (DISC-5) (Bitsko et al. 2019, Shaffer et al. 2000). Các rối loạn tâm thần được đo lường trong V-NAMHS bao gồm ám sợ xã hội (social phobia), rối loạn lo âu lan tỏa (generalised anxiety disorder), rối loạn trầm cảm chủ yếu (major depressive disorder), rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn hành vi (conduct disorder), và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Ám sợ xã hội và rối loạn lo âu lan tỏa được báo cáo chung là "các rối loạn lo âu" (anxiety disorders) trong báo cáo này. V-NAMHS cũng đo lường các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ liên quan đến sức khỏe tâm thần vị thành niên, bao gồm (nhưng không giới hạn) bắt nạt (bullying), trường học và giáo dục, mối quan hệ bạn bè và gia đình, hành vi tình dục, sử dụng chất gây nghiện (substance use), trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu (adverse childhood experiences), bệnh tâm thần của cha mẹ, và lòng tự trọng (self-esteem). Các câu hỏi liên quan đến sử dụng dịch vụ được hỏi về mức sử dụng, nhu cầu nhận thức được, và rào cản tiếp cận chăm sóc. Một mô-đun đánh giá các trải nghiệm liên quan trong đại dịch COVID-19 cũng được phát triển và đưa vào. Các thang đo này được chuyển thể và phát triển thông qua quy trình hợp tác với các đối tác NAMHS quốc tế (Erskine et al. 2021). Danh sách đầy đủ các thang đo có thể được tìm thấy trong Phụ lục 1: Công cụ đo lường.

Các công cụ ban đầu được phát triển bằng tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt, và dịch ngược lại tiếng Anh để kiểm tra tính nhất quán và chính xác về mặt khái niệm, tức là đảm bảo rằng ý nghĩa của các câu hỏi duy trì nhất quán với phiên bản tiếng Anh gốc. Phiên bản dịch cũng được rà soát bởi các bác sĩ lâm sàng Việt Nam, bởi những người tham gia đào tạo, và bởi nhóm V-NAMHS trên cơ sở liên tục trong suốt giai đoạn phát triển khảo sát trước khi thu thập dữ liệu.

**V-NAMHS được thực hiện khi nào?**

Thu thập dữ liệu cho V-NAMHS được tiến hành từ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến ngày 16 tháng 12 năm 2021, bắt đầu từ miền Bắc Việt Nam và di chuyển xuống miền Nam. Tổng cộng 127 phỏng vấn viên được đào tạo đã thu thập dữ liệu tại 38 tỉnh được chọn.

**COVID-19 có ảnh hưởng đến V-NAMHS không?**

COVID-19 đã ảnh hưởng đến tiến trình dự kiến của V-NAMHS. Thu thập dữ liệu ban đầu được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 6 năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại một năm đến tháng 6 năm 2021 do COVID-19. Tuy nhiên, sự bùng phát COVID-19 tại các tỉnh phía Nam vào giữa năm 2021 có nghĩa là cả việc chuẩn bị cho thu thập dữ liệu (tức là đào tạo) và bản thân việc thu thập dữ liệu đều bị trì hoãn thêm.

Trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19, việc di chuyển của người dân giữa các tỉnh bị hạn chế. Đào tạo phỏng vấn viên, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp trực tuyến bởi nhóm V-NAMHS tại IOS. Điều này làm tăng sự phụ thuộc vào hiệu suất của từng phỏng vấn viên trong khi số lượng phỏng vấn viên cần thiết cao hơn so với kế hoạch ban đầu do hạn chế di chuyển và nhu cầu phỏng vấn viên phải là người địa phương, tức là thay vì có phỏng vấn viên di chuyển giữa các tỉnh. Để giải quyết vấn đề này, các buổi đào tạo bồi dưỡng (refresher trainings) đã được tiến hành bao gồm nội dung của công cụ, phương pháp tiếp cận các hộ gia đình được chọn, và các biện pháp đảm bảo an toàn cho phỏng vấn viên và người tham gia. Hơn nữa, mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo chất lượng dữ liệu và một quy trình giám sát và kiểm tra chất lượng dữ liệu toàn diện đã được triển khai với sự hỗ trợ từ JHSPH và UQ. Việc trì hoãn thu thập dữ liệu cũng tạo cơ hội để phát triển và đưa vào một mô-đun COVID-19 nhằm đánh giá tác động của đại dịch đến vị thành niên và gia đình họ trong bối cảnh sức khỏe tâm thần. Thu thập dữ liệu cuối cùng bắt đầu vào tháng 9 năm 2021 tại miền Bắc, tiếp theo là miền Nam vào cuối năm 2021 khi tình hình COVID-19 cho phép.

**Phạm vi của báo cáo này là gì?**

Báo cáo này trình bày các kết quả chính từ V-NAMHS phản ánh các mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu và có liên quan đến các bên liên quan Việt Nam. Báo cáo có ba chương chính: sức khỏe tâm thần (bao gồm hành vi tự tử và tự gây thương tích), sử dụng dịch vụ, và COVID-19. Đặc điểm mẫu khảo sát (tức là nhân khẩu học) được đưa vào trong khi các thông tin khác liên quan đến phương pháp nghiên cứu và tiến hành khảo sát được đưa vào Phụ lục 2. Trừ khi được nêu rõ, tất

cả các kết quả (tỷ lệ và con số) đã được trọng số hóa (weighted) để đại diện cho phân bố tuổi-giới tính và thành thị-nông thôn của quần thể vị thành niên Việt Nam từ 10-17 tuổi. Mặc dù các kiểm định ý nghĩa thống kê (tests of statistical significance) không được đưa vào báo cáo này, các khác biệt có ý nghĩa thống kê đã được làm nổi bật trong bảng hoặc văn bản liên quan. Chỉ các khác biệt có ý nghĩa thống kê mới được thảo luận trong văn bản.

## ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT

Bảng 2 và 3 cho thấy đặc điểm nhân khẩu học của mẫu vị thành niên trong khi Bảng 4 cho thấy đặc điểm nhân khẩu học của mẫu phụ huynh. Tất cả các kết quả được báo cáo trong các bảng này đều chưa trọng số hóa (unweighted). Tất cả thông tin nhân khẩu học được phụ huynh báo cáo và nhập vào biểu mẫu thu thập dữ liệu vị thành niên trước cuộc phỏng vấn vị thành niên. Khi có sự khác biệt giữa biểu mẫu thu thập dữ liệu phụ huynh và vị thành niên, các khác biệt này được giải quyết bằng các phương pháp đã định trước.

### Vị thành niên

Bảng 2 cho thấy tuổi và giới tính của vị thành niên tham gia khảo sát (n = 5,996). Tuổi trung bình của các vị thành niên tham gia là 13.3 tuổi, với vị thành niên nhỏ tuổi hơn từ 10-13 tuổi chiếm hơn một nửa (54.2%) mẫu vị thành niên. Về phân bố giới tính, mẫu bao gồm nhiều nữ (52.61%) hơn nam (47.5%).

**Bảng 2. Mẫu vị thành niên theo giới tính và nhóm tuổi**

| Tuổi (năm) | Nam | | Nữ | | Tổng | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | % | n | % | n | % | n |

| 10-13 | 28.5 | 1,709 | 25.7 | 1,539 | 54.2 | 3,248 |

| 14-17 | 24.1 | 1,442 | 21.8 | 1,306 | 45.8 | 2,748 |

| 10-17 | 52.6 | 3,151 | 47.5 | 2,845 | 100.0 | 5,996 |

# Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam (V-NAMHS) - Phần 2

## Bảng 3. Mẫu vị thành niên theo tình trạng học vấn và việc làm

| Chỉ số | % | n |

|---|---|---|

| **Tình trạng học vấn** | | |

| Đang đi học | 94.5 | 5,666 |

| Hiện không đi học nhưng đã đi học trong 12 tháng qua | 1.0 | 62 |

| Đã đi học nhưng không trong 12 tháng qua | 4.4 | 263 |

| Chưa bao giờ đi học | 0.1 | 5 |

| **Tình trạng việc làm** | | |

| Đang có việc làm | 3.0 | 179 |

| Hiện không có việc làm nhưng đã có việc làm trong 12 tháng qua | 1.3 | 79 |

| Đã có việc làm nhưng không trong 12 tháng qua | 1.1 | 64 |

| Chưa bao giờ có việc làm | 94.6 | 5,674 |

| Hiện không đi học VÀ không có việc làm | 3.2 | 194 |

## Phụ huynh

Bảng 4 cho thấy các đặc điểm nhân khẩu học của mẫu phụ huynh. Tuổi trung bình của phụ huynh tham gia là 44.2 tuổi và đa số là mẹ hoặc mẹ kế của vị thành niên (63.6%). Gần một nửa (47%) chỉ hoàn thành giáo dục tiểu học hoặc trung học cơ sở, trong khi gần một phần tư (24.1%) chỉ hoàn thành trung học phổ thông. Về việc làm, hơn một nửa (54.1%) cho biết họ làm việc toàn thời gian. Khoảng một nửa (53.7%) cho biết họ là chủ hộ gia đình.

## Bảng 4. Mẫu người chăm sóc chính theo thông tin nhân khẩu học

| Chỉ số | % | n |

|---|---|---|

| Tuổi (trung bình, năm) ^a | 44.2 | |

| **Giới tính** | | |

| Nam | 28.3 | 1,695 |

| Nữ | 71.7 | 4,301 |

| **Mối quan hệ với vị thành niên** | | |

| Mẹ/mẹ kế | 63.6 | 3,814 |

| Cha/cha kế | 25.0 | 1,497 |

| Ông bà | 10.3 | 616 |

| Khác | 1.1 | 66 |

| **Tình trạng hôn nhân** | | |

| Đã kết hôn | 89.6 | 5,374 |

| Chưa từng kết hôn | 0.9 | 53 |

| Khác | 9.2 | 554 |

| **Trình độ học vấn (cấp cao nhất hoàn thành)** | | |

| Không có (chưa hoàn thành tiểu học) | 4.1 | 247 |

| Tiểu học | 14.5 | 872 |

| Trung học cơ sở | 32.4 | 1,945 |

| Trung học phổ thông | 24.1 | 1,446 |

| Trường nghề/dạy nghề hoặc tương đương (ví dụ: trung cấp chuyên nghiệp) | 4.8 | 289 |

| Giáo dục đại học | 19.2 | 1,152 |

| Đang đi học | 1.7 | 101 |

| **Tình trạng việc làm** | | |

| Toàn thời gian | 54.1 | 3,246 |

| Bán thời gian/thời vụ | 33.9 | 2,031 |

| Không có việc nhưng đang tìm việc | 1.1 | 68 |

| Không có việc và không tìm việc | 10.2 | 613 |

| Tỷ lệ đồng thời là chủ hộ gia đình ^b | 53.7 | 3,220 |

^a n = 5,987 (sau khi loại trừ những người dưới 18 tuổi [n=5] và các câu trả lời không có ý nghĩa [n=4]); ^b Chủ hộ không được xác định ở tất cả các hộ gia đình

## Sức khỏe Tâm thần (Mental Health)

### Tổng quan

Vị thành niên từ 10-19 tuổi chiếm 14.3% dân số Việt Nam (General Statistical Office 2020). Tuy nhiên, còn tương đối ít thông tin về tỷ lệ hiện mắc các rối loạn tâm thần (mental disorders) ở vị thành niên Việt Nam. Đây là một khoảng trống quan trọng vì nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng các rối loạn tâm thần trong giai đoạn vị thành niên, đặc biệt là những rối loạn không được điều trị hoặc điều trị không đầy đủ, có thể dẫn đến các hậu quả bất lợi trong suốt cuộc đời (Erskine et al. 2016, Ormel 2017). Một tổng quan tài liệu trước đây đã tìm thấy các ước tính tỷ lệ hiện mắc rất khác nhau về các vấn đề sức khỏe tâm thần (mental health problems) ở Việt Nam, dao động từ 8% đến 29% (Samuels et al. 2018).

Tuy nhiên, các tài liệu hiện có về rối loạn tâm thần vị thành niên ở Việt Nam có xu hướng bị hạn chế bởi cỡ mẫu nhỏ, phạm vi địa lý hoặc độ tuổi hạn hẹp, chỉ nghiên cứu một hoặc ít loại rối loạn tâm thần, và thiếu các nghiên cứu sử dụng công cụ chẩn đoán (diagnostic measures) (tức là các công cụ được thiết kế để xác định các rối loạn tâm thần đáp ứng các tiêu chí đã được thiết lập). Điều này có nghĩa là khả năng tổng quát hóa của các nghiên cứu này và khả năng cung cấp thông tin cũng như ảnh hưởng đến chính sách là hạn chế. Ví dụ, một nghiên cứu đại diện quốc gia về sức khỏe tâm thần ở trẻ em 6-16 tuổi đã sử dụng Bảng câu hỏi Điểm mạnh và Khó khăn (Strengths and Difficulties Questionnaire - SDQ) cho 1,314 phụ huynh và 591 vị thành niên (những người trong mẫu từ 12-16 tuổi) (Weiss et al. 2014). Trong nhóm mẫu vị thành niên cụ thể, từ 10.7% (báo cáo của vị thành niên) đến 11.9% (báo cáo của phụ huynh) đạt ngưỡng 'ranh giới' (borderline) cho một vấn đề sức khỏe tâm thần. Tỷ lệ tương tự về các vấn đề cảm xúc và hành vi (12.4% và 11.3%) được tìm thấy trong cùng nghiên cứu sử dụng thang tự báo cáo của thanh thiếu niên (Youth Self-Report - YSR) và Bảng kiểm hành vi trẻ em do phụ huynh báo cáo (Child Behaviour Checklist - CBCL) (Weiss et al. 2014). Tuy nhiên, mặc dù nghiên cứu này có

tính đại diện quốc gia, các công cụ đo lường được sử dụng là thang triệu chứng (symptom scales) được thiết kế để sàng lọc các triệu chứng sức khỏe tâm thần kém hoặc các vấn đề cảm xúc và hành vi rộng hơn, chứ không phải là công cụ chẩn đoán (diagnostic instruments) được thiết kế để chẩn đoán rối loạn tâm thần theo các định nghĩa và tiêu chí đã được thiết lập.

Hạn chế này đúng với hầu hết các nghiên cứu hiện có về tỷ lệ hiện mắc rối loạn tâm thần vị thành niên ở Việt Nam. Ví dụ, một nghiên cứu đã sử dụng SDQ để đo lường các vấn đề sức khỏe tâm thần ở vị thành niên từ 12-17 tuổi sống ở khu vực đô thị (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Điện Biên Phủ, thành phố Long Xuyên) và nông thôn (Keo Lom và thị trấn Phú Mỹ) (Samuels et al. 2018). Trong số 402 vị thành niên được lấy mẫu, 13.4% nằm trong vùng 'bất thường' (abnormal) của SDQ. Hơn nữa, cỡ mẫu tương đối nhỏ (n = 402) khiến việc tổng quát hóa các kết quả này cho quần thể vị thành niên Việt Nam trở nên khó khăn. Mặc dù các nghiên cứu này đóng góp quan trọng vào sự hiểu biết của chúng ta về sức khỏe tâm thần vị thành niên tại Việt Nam, chúng không thể được tổng quát hóa để cung cấp thông tin về tỷ lệ hiện mắc rối loạn tâm thần ở cấp quốc gia. Do đó, bằng chứng để xây dựng chính sách sức khỏe tâm thần vị thành niên tại Việt Nam và khả năng hành động hiệu quả và tích cực cho sức khỏe tâm thần vị thành niên là cực kỳ hạn chế.

Mục tiêu cốt lõi của V-NAMHS là tạo ra các ước tính tỷ lệ hiện mắc mang tính đại diện quốc gia về rối loạn tâm thần ở vị thành niên Việt Nam. Chương này trình bày phương pháp đo lường rối loạn tâm thần trong V-NAMHS và trình bày các kết quả. Các phát hiện về vấn đề sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần được trình bày, ngoài ra, tỷ lệ hiện mắc của hành vi tự tử (suicidal behaviours) và tự gây thương tích (self-harm) cũng được trình bày trong bối cảnh sức khỏe tâm thần. Tất cả các tỷ lệ và con số trình bày trong chương này đều được tính trọng số (weighted). Mặc dù các kiểm định ý nghĩa thống kê không được đưa vào chương này hay báo cáo nói chung, các khác biệt có ý nghĩa thống kê đã được làm nổi bật trong bảng liên quan và chỉ những khác biệt có ý nghĩa thống kê mới được thảo luận trong văn bản. Cuối cùng, các lưu ý liên quan đến việc diễn giải các kết quả này được thảo luận ngắn gọn trong khi các hàm ý cho các nhà hoạch định chính sách được nêu ra.

## Đo lường (Measurement)

### Công cụ đo lường (Measures)

Các mô-đun chẩn đoán từ DISC-5 được sử dụng để đánh giá tỷ lệ hiện mắc của các rối loạn tâm thần được chọn trong 12 tháng qua. DISC-5 là một công cụ chẩn đoán chuẩn hóa (standardised diagnostic instrument) (Bitsko et al. 2019, Shaffer et al. 2000) được phát triển lần đầu bởi Đại học Columbia thông qua sự hỗ trợ của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ (United States National Institute of Mental Health). DISC-5 được thiết kế để thực hiện bởi người phỏng vấn 'không chuyên' (lay interviewers) đã được đào tạo, tức là những người không có đào tạo lâm sàng nhưng được đào tạo về DISC-5. DISC-5 được sử dụng để đánh giá sáu rối loạn tâm thần trong V-NAMHS: ám ảnh sợ xã hội (social phobia), rối loạn lo âu lan tỏa (generalised anxiety disorder), rối loạn trầm cảm chủ yếu (major depressive disorder), rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), rối loạn hành vi (conduct disorder), và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Các rối loạn này được chọn vì chúng phổ biến ở tuổi vị thành niên và chịu trách nhiệm cho một tỷ lệ đáng kể gánh nặng rối loạn tâm thần ở nhóm tuổi này (Erskine et al. 2015). Ám ảnh sợ xã hội và rối loạn lo âu lan tỏa được báo cáo chung là 'rối loạn lo âu' (anxiety disorders) trong báo cáo này. Ngoại trừ ADHD (được hỏi phụ huynh), tất cả các mô-đun DISC-5 (tức là các thang đo rối loạn riêng lẻ) đều được thực hiện với vị thành niên.

Các thang đo về hành vi tự tử (suicidal behaviours) và tự gây thương tích (self-harm) cũng được đưa vào. Hành vi tự tử bao gồm: 1) ý tưởng tự tử (suicidal ideation) (những suy nghĩ nghiêm túc về việc kết thúc cuộc sống); 2) lập kế hoạch tự tử (suicide planning) (lập kế hoạch để kết thúc cuộc sống); và 3) mưu toan tự tử (suicide attempts) (hành động tự gây thương tích nhằm mục đích kết thúc cuộc sống). Tự gây thương tích (self-harm) có nghĩa là cố ý làm tổn thương hoặc gây thương tích cho bản thân mà không cố gắng kết thúc cuộc sống (tức là tự gây thương tích không có ý định tự tử - non-suicidal self-injury). Tất cả vị thành niên đều được hỏi các câu hỏi liên quan đến hành vi tự tử và tự gây thương tích bất kể tình trạng rối loạn tâm thần của họ. Đối với hành vi tự tử trong 12 tháng qua cụ thể, vị thành niên chỉ được hỏi về lập kế hoạch tự tử nếu họ báo cáo ý tưởng tự tử, và chỉ được hỏi về mưu toan tự tử nếu họ báo cáo lập kế hoạch tự tử.

**Vấn đề sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần (Mental health problems and mental disorders)**

Nội dung và cấu trúc của DISC-5 được thiết kế để tuân theo các tiêu chí chẩn đoán đã được thiết lập cho rối loạn tâm thần và gần đây đã được cập nhật để đáp ứng Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê các Rối loạn Tâm thần, Phiên bản thứ Năm (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition - DSM-5) (American Psychiatric Association 2013). Việc chẩn đoán rối loạn tâm thần theo DSM-5 yêu cầu một cá nhân phải xác nhận các triệu chứng cốt lõi của một rối loạn tâm thần nhất định và đáp ứng các ngưỡng cụ thể về thời gian, tần suất, mức độ nghiêm trọng và biểu hiện của các triệu chứng này, đồng thời báo cáo mức độ suy giảm chức năng (impairment) tối thiểu do các triệu chứng này gây ra. Các câu hỏi trong DISC-5 phản ánh điều này bằng cách đầu tiên hỏi về một triệu chứng nhất định và sau đó hỏi thêm các câu hỏi chi tiết về các đặc điểm cụ thể của triệu chứng này theo yêu cầu để chẩn đoán. Điều này phân biệt một công cụ chẩn đoán, như DISC-5, với các 'thang triệu chứng' (symptom scales) chỉ hỏi về sự hiện diện chung của một triệu chứng. Do đó, thang triệu chứng có xu hướng báo cáo tỷ lệ hiện mắc cao hơn nhiều so với công cụ chẩn đoán (COVID-19 Mental Disorders Collaborators 2021, Ferrari et al. 2013, GBD 2019 Mental Disorders Collaborators 2022) vì chúng đang đánh giá triệu chứng, không phải rối loạn.

Tuy nhiên, các cá nhân vẫn có thể trải qua đau khổ (distress) và suy giảm chức năng liên quan mà không nhất thiết đáp ứng tiêu chí DSM-5 để chẩn đoán một rối loạn tâm thần cụ thể. Những cá nhân này có thể là một nhóm quan trọng cần can thiệp trước khi tiến triển thành rối loạn tâm thần hoàn chỉnh (Pagliaro et al. 2021). Song song đó, các câu hỏi cũng đã được đặt ra về tính áp dụng của tiêu chí chẩn đoán DSM-5 đối với các nền văn hóa phi phương Tây cũng như tác động của các yếu tố văn hóa khi sử dụng một công cụ chuẩn hóa như DISC-5 (Canino and Alegria 2008).

Nhận thức được những thách thức tiềm tàng này, hai bộ kết quả được trình bày. Thứ nhất, tỷ lệ hiện mắc của 'vấn đề sức khỏe tâm thần' (mental health problems) được báo cáo, theo mục đích của báo cáo này, bao gồm những cá nhân đáp ứng ít nhất một nửa số triệu chứng cho một rối loạn tâm thần nhất định theo DISC-5 nhưng không nhất thiết đáp ứng tất cả tiêu chí chẩn đoán theo DSM-5. Thứ hai, tỷ lệ hiện mắc của rối loạn tâm thần (mental disorders) được báo cáo. Điều này bao gồm những cá nhân đáp ứng tiêu chí chẩn đoán cho một rối loạn tâm thần theo DSM-5 (American Psychiatric Association 2013). Bảng 5 dưới đây đưa ra định nghĩa chung cho vấn đề

sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần, cũng như định nghĩa vận hành được áp dụng trong V-NAMHS. Thuật ngữ được sử dụng cho các loại vấn đề sức khỏe tâm thần so với rối loạn tâm thần cũng được trình bày.

**Bảng 5. Định nghĩa về vấn đề sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm thần**

| | Vấn đề sức khỏe tâm thần (Mental health problem) | Rối loạn tâm thần (Mental disorder) |

|---|---|---|

| **Định nghĩa chung** | Ảnh hưởng đến cách một người suy nghĩ, cảm nhận và hành xử, nhưng ở mức độ thấp hơn so với rối loạn tâm thần. Chúng có thể được trải nghiệm tạm thời, hoặc như một phản ứng cấp tính trước các áp lực của cuộc sống. | Hội chứng hoặc mô hình hành vi hoặc tâm lý có ý nghĩa lâm sàng xảy ra ở một cá nhân và có liên quan đến sự đau khổ hiện tại (ví dụ: triệu chứng đau đớn), khuyết tật (tức là suy giảm trong một hoặc nhiều lĩnh vực chức năng quan trọng), và/hoặc nguy cơ gia tăng đáng kể về tử vong, đau đớn, khuyết tật, hoặc mất tự do quan trọng. |

| **Định nghĩa áp dụng trong V-NAMHS** | Một vị thành niên được coi là có vấn đề sức khỏe tâm thần nếu ít nhất một nửa số triệu chứng cần thiết để chẩn đoán một rối loạn tâm thần nhất định được xác nhận (tức là 'triệu chứng dưới ngưỡng' - subthreshold symptoms). Vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần do đó bao gồm những người có triệu chứng dưới ngưỡng hoặc đủ ngưỡng, có hoặc không có suy giảm chức năng. Như vậy, nhóm này cũng bao gồm vị thành niên đáp ứng tiêu chí cho rối loạn tâm thần. | Một vị thành niên được coi là đáp ứng tiêu chí DSM-5 cho rối loạn tâm thần nếu tất cả triệu chứng bắt buộc (tức là 'triệu chứng đủ ngưỡng' - full threshold symptoms) và mức độ suy giảm chức năng do các triệu chứng này được xác nhận. Chẩn đoán này tuân theo các thuật toán chấm điểm chuẩn được cung cấp bởi các tác giả DISC-5. |

| **Thuật ngữ cho các loại** | Trầm cảm (Depression) | Rối loạn trầm cảm chủ yếu (Major depressive disorder) |

| | Lo âu (Anxiety) | Rối loạn lo âu (Anxiety disorders) |

| | Căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress) | PTSD |

| | Vấn đề hành vi (Conduct problems) | Rối loạn hành vi (Conduct disorder) |

| | Vấn đề về thiếu chú ý và/hoặc tăng động (Problems with inattention and/or hyperactivity) | ADHD |

## Kết quả (Findings)

### Vấn đề sức khỏe tâm thần (Mental health problems)

Một phần năm vị thành niên (21.7%) báo cáo có vấn đề sức khỏe tâm thần trong 12 tháng qua (Bảng 6). Không có sự khác biệt về tỷ lệ hiện mắc giữa nam và nữ, hoặc giữa nhóm vị thành niên nhỏ tuổi hơn (10-13 tuổi) và lớn tuổi hơn (14-17 tuổi).

**Bảng 6. Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của vấn đề sức khỏe tâm thần ở nhóm 10-17 tuổi theo giới tính và nhóm tuổi**

| Vấn đề sức khỏe tâm thần | 10-13 tuổi | | 14-17 tuổi | | 10-17 tuổi | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | % | n | % | n | % | n |

| Nam | 21.4 | 357 | 20.2 | 292 | 20.8 | 649 |

| Nữ | 20.2 | 302 | 25.3 | 350 | 22.6 | 651 |

| Tổng | 20.8 | 659 | 22.7 | 462 | 21.7 | 1,301 |

N có trọng số: nam = 3,119; nữ = 2,877; 10-13 tuổi = 3,167; 14-17 tuổi = 2,829

Như thể hiện trong Hình 1, lo âu (anxiety) có tỷ lệ hiện mắc cao nhất (18.6%) trong tất cả các vấn đề sức khỏe tâm thần.

**Hình 1. Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của vấn đề sức khỏe tâm thần ở nhóm 10-17 tuổi theo loại**

- Trầm cảm (Depression): 4.3%

- Lo âu (Anxiety): 18.6%

- Căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress): 1.0%

- Vấn đề hành vi (Conduct problems): 0.7%

- Vấn đề về thiếu chú ý và/hoặc tăng động (Problems with inattention and/or hyperactivity): 2.8%

Vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần sau đó được phân tích thêm để xác định tỷ lệ báo cáo suy giảm chức năng (impairment) do triệu chứng kết hợp với tỷ lệ báo cáo triệu chứng đủ ngưỡng (full threshold) so với dưới ngưỡng (subthreshold). Ngưỡng triệu chứng được dựa trên tiêu chí

DSM-5, trong đó triệu chứng dưới ngưỡng cho thấy ít nhất một nửa triệu chứng bắt buộc được đáp ứng trong khi triệu chứng đủ ngưỡng cho thấy tất cả triệu chứng bắt buộc được đáp ứng. Điều này có nghĩa là vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần được phân thành một trong bốn nhóm thể hiện trong Hình 2 dưới đây (lưu ý rằng triệu chứng đủ ngưỡng có suy giảm chức năng tương đương với những người đáp ứng tiêu chí cho rối loạn tâm thần). Như thể hiện trong Hình 2, hầu hết vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần báo cáo một mức độ suy giảm chức năng nhất định do triệu chứng tương ứng, dù xác nhận tất cả triệu chứng theo DSM-5 (3.3%) hay ít nhất một nửa triệu chứng bắt buộc (10.3%).

**Hình 2. Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của vấn đề sức khỏe tâm thần theo ngưỡng triệu chứng và xác nhận suy giảm chức năng ở nhóm 10-17 tuổi**

- Không đạt ngưỡng triệu chứng nào (No symptom threshold met): 78.3%

- **Vấn đề sức khỏe tâm thần (Mental health problems): 21.7%**

  - Triệu chứng đủ ngưỡng có suy giảm chức năng (rối loạn tâm thần) (Full threshold symptoms with impairment - mental disorder): 3.3%

  - Triệu chứng dưới ngưỡng có suy giảm chức năng (Subthreshold symptoms with impairment): 10.3%

  - Triệu chứng đủ ngưỡng không có suy giảm chức năng (Full threshold symptoms without impairment): 0.6%

  - Triệu chứng dưới ngưỡng không có suy giảm chức năng (Subthreshold symptoms without impairment): 7.5%

DISC-5 đánh giá suy giảm chức năng do triệu chứng gây ra (theo yêu cầu chẩn đoán DSM-5) qua bốn lĩnh vực: gia đình (vấn đề trong mối quan hệ với người chăm sóc, khó khăn khi dành thời gian với gia đình), bạn bè (khó khăn khi dành thời gian với bạn bè), trường học hoặc công việc (khó khăn với trường học hoặc công việc), và đau khổ cá nhân (personal distress). Suy giảm chức năng ở nhiều hơn một lĩnh vực có thể được xác nhận. Trong số những người báo cáo suy giảm chức năng (n = 819), hai phần ba (67.0%) báo cáo suy giảm chức năng trong lĩnh vực gia đình, trong khi gần một nửa báo cáo suy giảm chức năng liên quan đến bạn bè (47.0%) và trường học/công việc (45.4%) (Bảng 7).

**Bảng 7. Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của vấn đề sức khỏe tâm thần ở nhóm 10-17 tuổi xác nhận suy giảm chức năng theo lĩnh vực suy giảm**

| Lĩnh vực suy giảm chức năng (Impairment domain) | % | n |
|---|---|---|
| Gia đình (Family) | 67.0 | 549 |
| Bạn bè (Peers) | 47.0 | 384 |
| Trường học hoặc công việc (School or work) | 45.4 | 371 |
| Đau khổ cá nhân (Personal distress) | 34.6 | 284 |

N có trọng số = 819

**Rối loạn tâm thần (Mental disorders)**

Tiêu chí chẩn đoán DSM-5 cho bất kỳ rối loạn tâm thần nào được đáp ứng bởi 3.3% vị thành niên (n = 200), với dưới 1% (0.6%; n = 38) có hai hoặc nhiều rối loạn tâm thần trong 12 tháng qua. Không có sự khác biệt về tỷ lệ hiện mắc giữa nam (3.3%) và nữ (3.4%), hoặc nhóm nhỏ tuổi hơn (2.9%) và lớn tuổi hơn (3.9%). Như thể hiện trong Bảng 8, rối loạn lo âu (anxiety disorders) có tỷ lệ hiện mắc cao nhất (2.3%).

**Bảng 8. Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của rối loạn tâm thần ở nhóm 10-17 tuổi theo loại**

| Rối loạn tâm thần (Mental disorders) | % | n |
|---|---|---|
| Rối loạn lo âu (Anxiety disorders)* | 2.3 | 135 |
| Rối loạn trầm cảm chủ yếu (Major depressive disorder) | 0.9 | 51 |
| ADHD | 0.5 | 29 |
| PTSD | 0.3 | 19 |
| Rối loạn hành vi (Conduct disorder) | 0.2 | 12 |

* Tỷ lệ hiện mắc rối loạn lo âu cao hơn đáng kể so với tất cả các rối loạn tâm thần khác

Trong số những người có bất kỳ rối loạn tâm thần nào, suy giảm chức năng trong lĩnh vực gia đình lại là cao nhất với gần ba phần tư báo cáo suy giảm chức năng trong lĩnh vực này (Bảng 9).

**Bảng 9. Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của rối loạn tâm thần ở nhóm 10-17 tuổi theo lĩnh vực suy giảm chức năng**

| Lĩnh vực suy giảm chức năng (Impairment domain) | % | n |

|---|---|---|

| Gia đình (Family) | 74.2 | 149 |

| Bạn bè (Peers) | 63.3 | 127 |

| Trường học hoặc công việc (School or work) | 64.1 | 128 |

| Đau khổ cá nhân (Personal distress) | 51.8 | 104 |

N có trọng số = 200

**Hành vi tự tử và tự gây thương tích (Suicidal behaviours and self-harm)**

Ít vị thành niên báo cáo hành vi tự tử trong 12 tháng qua. Trong toàn bộ mẫu, trong 12 tháng qua, 1.4% báo cáo ý tưởng tự tử (suicidal ideation), 0.4% báo cáo lập kế hoạch tự tử (suicide plan), và 0.2% báo cáo mưu toan tự tử (suicide attempt). Chỉ 1.6% báo cáo từng mưu toan tự tử. Tuy nhiên, như thể hiện trong Bảng 10, hơn 70% những người báo cáo hành vi tự tử (ý tưởng, lập kế hoạch, và/hoặc mưu toan) trong 12 tháng qua có vấn đề sức khỏe tâm thần.

**Bảng 10. Hành vi tự tử ở nhóm 10-17 tuổi**

| | Ý tưởng tự tử trong 12 tháng qua | | Lập kế hoạch tự tử trong 12 tháng qua | | Mưu toan tự tử trong 12 tháng qua | | Từng mưu toan tự tử | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | % | n | % | n | % | n | % | n |

| Vấn đề sức khỏe tâm thần | 73.5 | 61 | 83.7 | 19 | 77.4 | 8 | 73.5 | 70 |

| Rối loạn tâm thần | 30.8 | 26 | 46.6 | 11 | 61.3 | 7 | 28.1 | 27 |

N có trọng số: ý tưởng tự tử (12 tháng) = 83; lập kế hoạch tự tử (12 tháng) = 23; mưu toan tự tử (12 tháng) = 11; mưu toan tự tử (từng) = 96

Tương tự, chỉ một tỷ lệ tương đối nhỏ (4.7%) báo cáo từng tự gây thương tích, với chỉ hơn 1% báo cáo đã tự gây thương tích trong 12 tháng qua (Bảng 11). Tuy nhiên, hơn ba phần tư (76.3%) những vị thành niên tự gây thương tích trong 12 tháng qua có vấn đề sức khỏe tâm thần.

**Bảng 11. Tự gây thương tích ở nhóm 10-17 tuổi**

| | Tự gây thương tích trong 12 tháng qua | | Từng tự gây thương tích | |

|---|---|---|---|---|

| | % | n | % | n |

| Vấn đề sức khỏe tâm thần | 76.3 | 50 | 64.5 | 182 |

| Rối loạn tâm thần | 29.0 | 19 | 20.9 | 59 |

N có trọng số: tự gây thương tích (12 tháng) = 66; tự gây thương tích (từng) = 283

## Các lưu ý (Considerations)

### Diễn giải (Interpretation)

V-NAMHS phát hiện rằng sức khỏe tâm thần kém là một vấn đề sức khỏe phổ biến ở vị thành niên. Cứ năm vị thành niên thì có một người (21.7%) có vấn đề sức khỏe tâm thần trong 12 tháng qua, với cứ ba mươi người thì có một người (3.3%) đáp ứng tiêu chí cho rối loạn tâm thần. Về mặt so sánh, có rất ít nghiên cứu đã sử dụng các công cụ chẩn đoán để đo lường tỷ lệ hiện mắc rối loạn tâm thần trong quần thể vị thành niên nói chung ở Việt Nam. Việc khắc phục các hạn chế phương pháp luận như vậy là đặc điểm cốt lõi của V-NAMHS và, do đó, so sánh trực tiếp với các nghiên cứu hiện có là khó khăn do sự khác biệt cơ bản về phương pháp luận. Ví dụ, phát hiện rằng 21.7% vị thành niên tham gia V-NAMHS có vấn đề sức khỏe tâm thần trong 12 tháng qua (tức là những người xác nhận ít nhất một nửa triệu chứng cần thiết cho chẩn đoán rối loạn tâm thần) nằm trong phạm vi của tổng quan tài liệu trước đây tìm thấy tỷ lệ hiện mắc vấn đề sức khỏe tâm thần dao động từ 8% đến 29% (Samuels et al. 2018). Tuy nhiên, so sánh có ý nghĩa giữa các thang đo khác nhau là hạn chế và không tìm thấy nghiên cứu tương đương nào để so sánh phát hiện 3.3% tỷ lệ hiện mắc rối loạn tâm thần. Sự thiếu vắng các nghiên cứu tương đương hiện có chứng minh khoảng trống bằng chứng đáng kể được V-NAMHS giải quyết, cũng như tầm quan trọng của việc sử dụng các thang đo toàn diện trên mẫu đại diện quốc gia để hiểu rõ hơn tỷ lệ hiện mắc rối loạn tâm thần trong quần thể vị thành niên.

Vị thành niên báo cáo hành vi tự tử hoặc tự gây thương tích trong 12 tháng qua có nhiều khả năng là những người có vấn đề sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, tỷ lệ hiện mắc chung của hành vi tự tử và tự gây thương tích trong V-NAMHS thấp hơn phần nào so với những gì đã được báo cáo trong các nghiên cứu trước đây. Ví dụ, Khảo sát Sức khỏe Học sinh Toàn cầu tại Trường học (Global School-based Student Health Survey - GSHS) năm 2019 tại Việt Nam cho thấy 15.6% vị thành niên từ 13-17 tuổi báo cáo ý tưởng tự tử trong 12 tháng qua, với thêm 3.1% báo cáo đã mưu toan tự tử trong 12 tháng qua (World Health Organization, Ministry of Health and Ministry of Education and Training 2022). Tuy nhiên, GSHS sử dụng bảng câu hỏi tự điền trong môi trường trường học. Do đó, có thể sự kỳ thị (stigma) xung quanh hành vi tự tử có thể giải thích một phần cho tỷ lệ hiện mắc thấp hơn trong V-NAMHS, nơi các câu hỏi về hành vi tự tử được thực hiện bởi người phỏng vấn. Hơn nữa, các phát hiện của GSHS cao hơn đáng kể so với các phát hiện liên quan khác tại Việt Nam. Ví dụ, một nghiên cứu lớn trên 6,191 người từ 15-24 tuổi tại Hà Nội báo cáo tỷ lệ hiện mắc 12 tháng của ý tưởng tự tử là 2.3%, với dưới 1% xác nhận đã mưu toan tự tử trong 12 tháng qua (Blum, Sudhinaraset and Emerson 2012). Một lần nữa, các tác giả báo cáo rằng các câu hỏi nhạy cảm được người tham gia tự điền. Ngoài ra, câu hỏi về ý tưởng tự tử kết hợp suy nghĩ tự tử với tự gây thương tích, và lập kế hoạch tự tử không được đưa vào như một danh mục riêng biệt. Điều này có thể giải thích thêm cho tỷ lệ hiện mắc cao hơn so với những gì thấy trong V-NAMHS.

**Hạn chế (Limitations)**

Mặc dù V-NAMHS được thiết kế có chủ đích để giải quyết các hạn chế phương pháp luận của các nghiên cứu hiện có, một số khía cạnh của phương pháp V-NAMHS có thể đã ảnh hưởng đến tỷ lệ hiện mắc được báo cáo. Ví dụ, phỏng vấn được thực hiện trực tiếp bởi người phỏng vấn đã được đào tạo. Có thể sự kỳ thị liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần và sự thiếu nhận thức chung về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng đã ảnh hưởng đến sự sẵn lòng tiết lộ thông tin của người tham gia, mặc dù đào tạo người phỏng vấn toàn diện, quyền riêng tư là yêu cầu của cuộc phỏng vấn, và tất cả người tham gia được thông báo rằng dữ liệu thu thập sẽ được ẩn danh. Một vấn đề tương tự có thể đã hiện diện với việc báo cáo hành vi tự tử và tự gây thương tích, do các hành vi này thường bị kỳ thị là không mong muốn và vị thành niên có thể miễn cưỡng báo cáo cho người phỏng vấn, dẫn đến tỷ lệ hiện mắc thấp hơn so với các nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi tự điền (Blum, Sudhinaraset and Emerson 2012, Hoàng Thế Hải and Bùi Thị Thanh Diệu 2021, United Nations Children's Funds (UNICEF) and Overseas Development Institute (ODI)

2018, World Health Organization, Ministry of Health and Ministry of Education and Training 2022).

Một thách thức nữa có thể liên quan đến các định nghĩa về rối loạn tâm thần theo DSM-5, vốn là cơ sở của DISC-5. DSM-5 được phát triển bởi Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (American Psychiatric Association) và phần lớn bao gồm các tiêu chí chẩn đoán dựa trên phương Tây (American Psychiatric Association 2013) có thể không tính đến sự khác biệt văn hóa trong cách sức khỏe tâm thần được mô tả, trải nghiệm hoặc biểu hiện trong quần thể Việt Nam. Ví dụ, Kim et al. (2019) phát hiện rằng các triệu chứng cơ thể (somatic symptoms) dự đoán triệu chứng lo âu và trầm cảm ở cả vị thành niên Việt Nam và người Mỹ gốc Việt nhưng không phải ở vị thành niên người Mỹ gốc Âu (Kim et al. 2019). Do đó, có thể các triệu chứng được DISC-5 kiểm tra (dựa trên tiêu chí chẩn đoán DSM-5) không giải thích đầy đủ các triệu chứng cơ thể liên quan đến sức khỏe tâm thần trong bối cảnh Việt Nam.

Để giải quyết những thách thức này, những nỗ lực đáng kể đã được thực hiện để điều chỉnh DISC-5 cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam trong khuôn khổ các yêu cầu chẩn đoán của DSM-5. Điều này bao gồm dịch thuật cẩn thận toàn bộ công cụ V-NAMHS (bao gồm DISC-5), dịch ngược (back-translation), và đánh giá các bản dịch ngược bởi các nhóm NAMHS. Các sửa đổi cũng được thực hiện dựa trên phản hồi từ người tham gia trong các đợt đào tạo ban đầu và dựa trên đánh giá bản dịch bởi các bác sĩ lâm sàng trong nước. Mục tiêu là đảm bảo ngôn ngữ của công cụ (bao gồm ngữ pháp, thành ngữ và ví dụ về hành vi) được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh Việt Nam trong khi vẫn đo lường cùng các khái niệm như dự định ban đầu. Các thay đổi cũng được thực hiện để đáp ứng nghiên cứu thí điểm (pilot study) (được mô tả thêm trong phần Phương pháp luận tại Phụ lục 2) và việc sửa đổi tiếp tục trong suốt năm 2019 và 2020. Cuối cùng, để hiểu rõ hơn sự tương tác tiềm tàng giữa khác biệt văn hóa trong sức khỏe tâm thần và các yêu cầu chẩn đoán của DSM-5, cả 'vấn đề sức khỏe tâm thần' và 'rối loạn tâm thần' đều được đưa vào báo cáo này. Điều này cho phép hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tâm thần của quần thể vị thành niên Việt Nam ngoài các yêu cầu chẩn đoán do DSM-5 thiết lập.

**Hàm ý (Implications)**

Tỷ lệ hiện mắc sức khỏe tâm thần kém được V-NAMHS phát hiện cho thấy sức khỏe tâm thần là một vấn đề y tế công cộng (public health) cần sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách và nhà lập kế hoạch tại Việt Nam. Dữ liệu từ V-NAMHS cung cấp nền tảng bằng chứng cho các

chính sách và sáng kiến y tế như vậy. Ví dụ, hầu hết vị thành niên đang đi học, có nghĩa là việc triển khai các chiến lược sàng lọc và quản lý cụ thể, kết hợp với các hoạt động nâng cao sức khỏe tâm thần (mental health promotion), trong môi trường trường học có thể là một phương tiện để giảm tỷ lệ hiện mắc và tác động tiềm tàng của các triệu chứng này đối với sức khỏe và hạnh phúc của vị thành niên Việt Nam. Hơn nữa, lo âu có tỷ lệ hiện mắc cao nhất trong tất cả các vấn đề sức khỏe tâm thần. Các chiến dịch nâng cao sức khỏe có mục tiêu tập trung vào cải thiện hiểu biết về lo âu, nhận biết triệu chứng, và cách tìm kiếm sự giúp đỡ có thể cung cấp con đường cải thiện sức khỏe tâm thần cho một phần lớn quần thể vị thành niên Việt Nam đang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, mặc dù tỷ lệ hiện mắc hành vi tự tử ở vị thành niên được báo cáo là thấp, nhưng vẫn cần sự quan tâm và hành động chính sách để giảm thiểu rủi ro khi vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết. Ý tưởng tự tử thường xuất hiện trong một khoảng thời gian trước khi lập kế hoạch hoặc mưu toan tự tử xảy ra (Wasserman et al. 2008). Do đó, phát hiện sớm và dịch vụ hỗ trợ cho những người trải qua ý tưởng tự tử, bao gồm thông qua nhận biết vấn đề sức khỏe tâm thần, có thể giúp tránh được mưu toan tự tử cuối cùng.

Một cách rộng hơn, các phát hiện của V-NAMHS nhấn mạnh nhu cầu về một chính sách sức khỏe tâm thần quốc gia xem xét đến vị thành niên và bao gồm các chiến lược cụ thể cho sức khỏe tâm thần của họ trong trường học và cộng đồng nói chung. Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1442/QĐ-BGDĐT ngày 1 tháng 6 năm 2022 (Ban hành Chương trình Giáo dục Sức khỏe Tâm thần cho Trẻ em và Học sinh giai đoạn 2022-2025) và Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT ngày 3 tháng 8 năm 2022 (Ban hành Kế hoạch Giáo dục Sức khỏe Tâm thần cho Trẻ em và Học sinh giai đoạn 2022-2025) (Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022a, Bộ Giáo dục và Đào tạo 2022b). Mặc dù các quyết định này thể hiện sự công nhận rộng rãi về sức khỏe tâm thần vị thành niên trong ngành giáo dục, cần một khung chính sách quốc gia toàn diện để giải quyết nhu cầu sức khỏe tâm thần của vị thành niên bao gồm cả những người đang đi học cũng như những người không đi học, và bao gồm sự tham gia của ngành y tế và các ngành liên quan khác cũng như ngành giáo dục. Hành động tích cực cho sức khỏe tâm thần vị thành niên có tiềm năng mang lại lợi ích hiện tại (tức là lợi ích được trải nghiệm ngay bây giờ bằng cách giảm nhẹ triệu chứng và cải thiện khả năng hoạt động tối ưu trong cuộc sống hàng ngày), lợi ích lâu dài (tức là lợi ích ở tuổi trưởng thành thông qua việc có thể tránh hoặc giảm thiểu các hậu quả bất lợi liên quan đến sức khỏe tâm thần), cũng như lợi ích tiềm năng cho thế hệ tiếp theo bằng cách có cha

mẹ khỏe mạnh về tâm thần và lớn lên trong một xã hội có các chính sách sức khỏe tâm thần đã được thiết lập (Patton et al. 2016).

## Sử dụng Dịch vụ (Service Use)

### Tổng quan

Sự khởi phát của triệu chứng rối loạn tâm thần có xu hướng xảy ra trong giai đoạn vị thành niên (World Health Organization 2014), mang lại cơ hội duy nhất để cung cấp can thiệp sớm (early intervention) và dịch vụ sức khỏe tâm thần phù hợp với vị thành niên (Colizzi, Lasalvia and Ruggeri 2020). Điều trị và hỗ trợ hiệu quả có thể giảm hoặc giải quyết triệu chứng và cải thiện chức năng, trong khi trải nghiệm tích cực sớm khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có thể thúc đẩy hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ trong tương lai, giảm gánh nặng cho cá nhân và hệ thống y tế khi bước vào tuổi trưởng thành (Schnyder et al. 2019). Thu thập thông tin về mô hình sử dụng dịch vụ có thể giúp xác định khoảng trống trong cung cấp dịch vụ, đánh giá liệu các dịch vụ sức khỏe tâm thần hiện có phù hợp và dễ tiếp cận hay không, và giải quyết các rào cản đối với việc chăm sóc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với vị thành niên, những người phải đối mặt với những thách thức riêng trong việc tiếp cận dịch vụ do áp lực gia đình, ảnh hưởng của bạn bè, và khó khăn trong việc chi trả cho dịch vụ (Person, Hagquist and Michelson 2017, World Health Organization 2014). Hiểu biết về những thách thức nào có liên quan nhất đến vị thành niên cho phép hành động trực tiếp để giảm rào cản nhằm cải thiện việc sử dụng dịch vụ và kết quả chăm sóc cho những người có vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc rối loạn tâm thần.

Tại Việt Nam, gần đây Chính phủ đã có những nỗ lực tăng cường tiếp cận dịch vụ sức khỏe tâm thần. Ví dụ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2020 (Thủ tướng Chính phủ 2020) phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người có rối loạn tâm thần giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, vị thành niên chỉ được đề cập như một trong nhiều tiểu quần thể và trọng tâm duy nhất về người trẻ chủ yếu liên quan đến trẻ em tự kỷ. Gần đây hơn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 155/QĐ-TTg ngày 29 tháng 1 năm 2022 (Thủ tướng Chính phủ 2022) phê duyệt "Kế hoạch Quốc gia về Phòng chống Bệnh không Lây nhiễm và Rối loạn Sức khỏe Tâm thần giai đoạn 2022-2025". Mặc dù một trong những mục tiêu của Kế hoạch là quản lý điều trị ở cấp quần thể để hạn chế gia tăng rối loạn tâm thần, trọng tâm vẫn là tâm thần phân liệt (schizophrenia) và trầm cảm (depression)

mà không chú ý đến các chiến lược dành riêng cho vị thành niên hoặc các rối loạn phổ biến khác trong giai đoạn vị thành niên (Thủ tướng Chính phủ 2022). Mặc dù ngày càng có sự công nhận về sức khỏe tâm thần tại Việt Nam nói chung, vẫn thiếu đáng kể các dịch vụ, đặc biệt ở khu vực nông thôn so với khu vực đô thị, với việc tiếp cận bị ảnh hưởng thêm bởi tình trạng kinh tế xã hội của cá nhân (Samuels et al. 2018).

Đối với vị thành niên, những thách thức này càng trầm trọng hơn khi hầu hết các dịch vụ sức khỏe tâm thần hiện có chủ yếu phục vụ người lớn có bệnh tâm thần nặng và yêu cầu phức tạp, như tâm thần phân liệt (Cao Tiến Đức 2020). Kết quả là, có sự thiếu hụt đáng kể dịch vụ sức khỏe tâm thần cho vị thành niên, đặc biệt cho những người trải qua suy giảm chức năng và đau khổ do triệu chứng rối loạn tâm thần nhưng không cần can thiệp chuyên sâu.

Một trong những mục tiêu chính của V-NAMHS là xác định việc sử dụng dịch vụ sức khỏe tâm thần trong vị thành niên Việt Nam, cũng như mức độ nhu cầu được nhận thức và rào cản đối với việc chăm sóc. Chương này trình bày phương pháp đo lường việc sử dụng dịch vụ và các yếu tố liên quan trong V-NAMHS và trình bày các kết quả. Tất cả tỷ lệ và con số trình bày trong chương này đều được tính trọng số. Mặc dù các kiểm định ý nghĩa thống kê không được đưa vào chương này hay báo cáo nói chung, các khác biệt có ý nghĩa thống kê đã được làm nổi bật trong bảng liên quan và chỉ những khác biệt có ý nghĩa thống kê mới được thảo luận trong văn bản. Cuối cùng, các lưu ý liên quan đến việc diễn giải các kết quả và hàm ý cho các nhà hoạch định chính sách được thảo luận ngắn gọn.

## Đo lường (Measurement)

Các câu hỏi về sử dụng dịch vụ được hỏi tất cả người tham gia, bất kể có xác nhận triệu chứng rối loạn tâm thần hay không. Để hiểu liệu dịch vụ đã được tiếp cận để hỗ trợ sức khỏe tâm thần của vị thành niên hay chưa, thuật ngữ 'các vấn đề về cảm xúc và hành vi' (emotional and behavioural problems) được sử dụng để đặt khung cho mỗi câu hỏi về sử dụng dịch vụ. Thuật ngữ này được chọn để giảm kỳ thị hoặc tác động tiềm tàng từ sự hiểu biết hạn chế về các thuật ngữ sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, 'các vấn đề về cảm xúc và hành vi' tính đến phạm vi rộng các cách mà triệu chứng rối loạn tâm thần có thể biểu hiện, có thể khác nhau giữa các nhóm tuổi và bối cảnh văn hóa. Cách tiếp cận này phù hợp với các nghiên cứu tương tự về sức khỏe tâm thần và sử dụng dịch vụ (Hafekost et al. 2016). Hơn nữa, V-NAMHS nhận thức rằng các dịch vụ được sử dụng có thể bao gồm các nhà cung cấp ngoài dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính thức. Vì lý do này, một

phạm vi rộng các nhà cung cấp dịch vụ đã được đưa vào các thang đo trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, tôn giáo/truyền thống, và các lĩnh vực khác. Tất cả câu hỏi liên quan đến 12 tháng qua, và tất cả đều được hỏi phụ huynh, ngoại trừ hỗ trợ không chính thức (informal support) và chiến lược tự giúp (self-help strategies) được hỏi vị thành niên.

## Kết quả (Findings)

### Tần suất và loại hình sử dụng dịch vụ (Service use frequency and type)

Trong số vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần (n = 1,301), chỉ 8.4% đã sử dụng bất kỳ dịch vụ nào cung cấp hỗ trợ hoặc tư vấn cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua. Tổng thể, chỉ 6.5% (n = 389) vị thành niên đã sử dụng dịch vụ trong 12 tháng qua, không có sự khác biệt giữa nam (7.4%; n = 231) và nữ (5.5%; n = 158). Trong số vị thành niên đã sử dụng dịch vụ, hầu hết phụ huynh cho biết dịch vụ hữu ích hoặc rất hữu ích (80.0%).

Về tần suất sử dụng dịch vụ trong 12 tháng qua, Bảng 12 cho thấy một nửa (50.8%) vị thành niên này chỉ sử dụng dịch vụ một lần, trong khi một phần tư (26.2%) đã sử dụng dịch vụ hai đến bốn lần. Rất ít (3.4%) vị thành niên đã tiếp cận dịch vụ năm lần trở lên.

**Bảng 12. Tần suất tiếp cận dịch vụ cung cấp hỗ trợ hoặc tư vấn cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua ở nhóm 10-17 tuổi theo giới tính**

| Giới tính | Một lần | | 2-4 lần | | 5 lần trở lên | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | % | n | % | n | % | n |

| Nam | 47.2 | 109 | 26.3 | 61 | 4.5 | 10 |

| Nữ | 56.0 | 89 | 26.2 | 41 | 1.7 | 3 |

| Tổng | 50.8 | 198 | 26.2 | 102 | 3.4 | 13 |

N có trọng số: nam = 231; nữ = 158; tổng = 389

Khi được hỏi nhà cung cấp dịch vụ nào được sử dụng nhiều nhất trong 12 tháng qua, hơn một nửa phụ huynh (56.2%) có vị thành niên tiếp cận dịch vụ trong 12 tháng qua cho biết đó là từ bác sĩ hoặc y tá (Bảng 13).

**Bảng 13. Nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng nhiều nhất cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua ở nhóm 10-17 tuổi**

| Loại nhà cung cấp dịch vụ | % | n |
|---|---|---|
| Bác sĩ hoặc y tá (Doctor or nurse) | 56.2 | 219 |
| Nhân viên y tế cộng đồng (Community health worker) | 10.7 | 42 |
| Nhân viên trường học (School staff) | 5.5 | 22 |
| Lãnh đạo tôn giáo/tín ngưỡng (Religious/faith leader) | 4.5 | 17 |
| Chuyên gia, ví dụ: bác sĩ tâm thần (Specialist e.g., psychiatrist) | 1.4 | 5 |
| Khác (Other) | 0.3 | 1 |
| Thầy thuốc truyền thống (Traditional healer) | 0.1 | 0 |

N có trọng số = 389

Trong số những người đã tiếp cận dịch vụ, 28.1% có vấn đề sức khỏe tâm thần trong 12 tháng qua, có nghĩa là hơn 71.9% không báo cáo đủ triệu chứng để chỉ ra sự hiện diện của vấn đề sức khỏe tâm thần theo DISC-5. Như thể hiện trong Hình 3, vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần đã tiếp cận dịch vụ có nhiều khả năng báo cáo suy giảm chức năng hơn là không, bất kể họ xác nhận triệu chứng đủ ngưỡng (14.8%, n = 16) hay dưới ngưỡng (60.1%, n = 66).

**Hình 3. Ngưỡng triệu chứng và xác nhận suy giảm chức năng ở nhóm 10-17 tuổi có vấn đề sức khỏe tâm thần sử dụng dịch vụ trong 12 tháng qua**

- Triệu chứng đủ ngưỡng có suy giảm chức năng (rối loạn tâm thần) (Full threshold symptoms with impairment - mental disorder): 14.8%

- Triệu chứng dưới ngưỡng có suy giảm chức năng (Subthreshold symptoms with impairment): 60.1%

- Triệu chứng đủ ngưỡng không có suy giảm chức năng (Full threshold symptoms without impairment): 0.4%

- Triệu chứng dưới ngưỡng không có suy giảm chức năng (Subthreshold symptoms without impairment): 24.7%

N có trọng số = 109

**Nhu cầu được nhận thức và rào cản đối với chăm sóc (Perceived need and barriers to care)**
Trong tất cả phụ huynh, chỉ 5.1% (n = 307) xác định rằng con vị thành niên của họ cần được giúp đỡ cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi. Trong số những người xác định rằng con vị thành niên cần được giúp đỡ, 37.7% (n = 116) cho biết con vị thành niên đã nhận được tất cả sự giúp đỡ cần thiết. Như thể hiện trong Bảng 14, một phần năm phụ huynh (20.4%) cho biết thích tự xử lý vấn đề của con vị thành niên một mình hoặc với sự hỗ trợ của gia đình, trong khi cứ mười người thì có một người cho biết không biết liệu con vị thành niên có cần giúp đỡ không (10.7%) và/hoặc không biết đến đâu để được giúp đỡ (10.0%). Lưu ý rằng phụ huynh có thể xác nhận nhiều lựa chọn ngoại trừ những người cho biết không có lý do nào trong danh sách áp dụng.

**Bảng 14. Rào cản đối với việc tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc nhận sự giúp đỡ cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua ở phụ huynh của nhóm 10-17 tuổi**

| Lý do | % | n |

|---|---|---|

| Thích tự xử lý vấn đề của con vị thành niên một mình hoặc với sự hỗ trợ của gia đình | 20.4 | 63 |

| Không chắc liệu con vị thành niên có cần giúp đỡ không | 10.7 | 33 |

| Không chắc nên tìm sự giúp đỡ ở đâu | 10.0 | 30 |

| Nghĩ rằng vấn đề sẽ tự khỏi | 5.8 | 18 |

| Không có nơi nào để nhận sự giúp đỡ | 3.8 | 12 |

| Chi phí quá cao hoặc gia đình không đủ khả năng chi trả | 2.7 | 8 |

| Không có lý do nào trong số này (khác) ^a | 2.4 | 7 |

| Có vấn đề trong việc đến nơi cung cấp dịch vụ | 2.0 | 6 |

| Lo lắng về suy nghĩ của người khác | 1.3 | 4 |

| Không muốn nói về vấn đề này với người lạ | 1.3 | 4 |

| Con vị thành niên từ chối giúp đỡ hoặc không đến buổi hẹn | 0.7 | 2 |

| Đã yêu cầu giúp đỡ nhưng không nhận được | 0.6 | 2 |

N có trọng số = 307; ^a chỉ được chọn một lựa chọn duy nhất

### Hỗ trợ không chính thức (Informal support)

Tất cả vị thành niên được hỏi họ thường nói chuyện với ai khi có lo lắng hoặc quan ngại. Họ có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn ngoại trừ những người xác nhận không nói chuyện với ai (9.5%). Trong số những người cho biết họ có nói chuyện với ai đó, gần ba phần tư (73.9%) vị thành niên xác nhận nói chuyện với thành viên gia đình, tiếp theo là gần hai phần năm cho biết nói chuyện với bạn bè (38.2%) (Bảng 15).

**Bảng 15. Người được nói chuyện khi có lo lắng hoặc quan ngại ở nhóm 10-17 tuổi**

| Vị thành niên thường nói chuyện với ai khi có lo lắng hoặc quan ngại | % | n |

|---|---|---|

| Thành viên gia đình (Family member) | 73.9 | 4,429 |

| Bạn bè (Friend) | 38.2 | 2,288 |

| Giáo viên (Teacher) | 2.9 | 176 |

| Bạn trai/bạn gái (Partner - boyfriend/girlfriend) | 2.3 | 137 |

| Thành viên cộng đồng (Community member) | 1.6 | 94 |

| Khác (Other) | 1.0 | 60 |

| Bác sĩ (Doctor) | 0.5 | 31 |

| Lãnh đạo tôn giáo/tín ngưỡng (Religious/faith leader) | 0.4 | 22 |

### Chiến lược tự giúp (Self-help strategies)

Tất cả vị thành niên được hỏi về chiến lược quản lý và phòng ngừa các vấn đề về cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua. Vị thành niên có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn trừ khi cho biết không sử dụng chiến lược tự giúp nào (11.7%). Bảng 16 cho thấy 30.7% xác nhận tập thể dục nhiều hơn trong khi một phần tư (24.8%) cho biết họ làm nhiều hơn những điều họ thích.

**Bảng 16. Chiến lược tự giúp được sử dụng để quản lý hoặc phòng ngừa các vấn đề về cảm xúc và hành vi ở nhóm 10-17 tuổi**

| Chiến lược tự giúp (Self-help strategy) | % | n |

|---|---|---|

| Tập thể dục nhiều hơn hoặc tham gia thể thao (Did more exercise or took up a sport) | 30.7 | 1,839 |

| Làm nhiều hơn những điều bản thân thích (Did more of the things you enjoy) | 24.8 | 1,490 |

| Tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình (Sought support from family) | 19.2 | 1,149 |

| Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè (Sought support from friends) | 17.7 | 1,060 |

| Cải thiện chế độ ăn uống (Improved your diet) | 14.7 | 884 |

| Tìm kiếm thông tin trong sách, tạp chí hoặc trên TV (Sought information in books, magazines or on TV) | 9.0 | 538 |

| Tìm kiếm hỗ trợ qua mạng xã hội như phòng trò chuyện trực tuyến, mạng xã hội hoặc các nhóm internet khác (Sought support through social networking such as online chat rooms, social media or other internet groups) | 6.9 | 416 |

| Tham gia một nhóm xã hội nào đó (Joined a social group of some kind) | 1.7 | 104 |

| Thiền định hoặc liệu pháp thư giãn (Meditated or did relaxation therapy) | 1.6 | 97 |

| Bỏ hút thuốc, uống rượu hoặc sử dụng ma túy (Stopped smoking, drinking alcohol or using drugs) | 0.2 | 14 |

## Các lưu ý (Considerations)

### Diễn giải (Interpretation)

Các kết quả cho thấy nhu cầu chưa được đáp ứng tiềm tàng lớn về dịch vụ sức khỏe tâm thần cho vị thành niên tại Việt Nam. Trong số vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần (21.7%; n = 1,301), chỉ 8.4% (n = 109) đã sử dụng bất kỳ dịch vụ nào cung cấp hỗ trợ hoặc tư vấn cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua. Phát hiện này phù hợp với các khảo sát quốc tế cho thấy hầu hết người dân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (low- and middle-income countries - LMICs) có rối loạn tâm thần không được điều trị (Demyttenaere et al. 2004).

Các phát hiện về rào cản đối với chăm sóc có thể cung cấp một số manh mối về lý do tại sao việc tiếp cận dịch vụ thấp trong số những người có vấn đề sức khỏe tâm thần. Chỉ 5.1% (n = 307) phụ huynh cho biết con vị thành niên cần được giúp đỡ cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi trong

12 tháng qua. Trong số những người cho biết, gần hai phần năm (37.7%) báo cáo rằng con vị thành niên đã nhận được tất cả sự giúp đỡ cần thiết, với thêm 20.4% thích tự xử lý vấn đề của con vị thành niên một mình hoặc với sự hỗ trợ của gia đình. Mặc dù có thể một số vị thành niên thực sự đã nhận được sự giúp đỡ đầy đủ, nhưng các phát hiện này có thể cho thấy vấn đề về hiểu biết sức khỏe tâm thần (mental health literacy), đặc biệt liên quan đến việc nhận biết các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể cần sự giúp đỡ chuyên môn. Điều này được hỗ trợ bởi các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam (Hoang-Minh Dang et al. 2020). Cũng có thể có tác động của sự kỳ thị xung quanh sức khỏe tâm thần, trong đó khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ cho vấn đề sức khỏe tâm thần bị giảm. Nghiên cứu trước đây đã phát hiện sự kỳ thị hiện có về sức khỏe tâm thần trong quần thể Việt Nam ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ (Kamimura et al. 2018, Mai Do et al. 2014).

Ngược lại, chỉ 28.1% những người tiếp cận dịch vụ có vấn đề sức khỏe tâm thần. Điều này có nghĩa là 71.9% những người tiếp cận dịch vụ cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi không báo cáo đủ triệu chứng để chỉ ra vấn đề sức khỏe tâm thần theo DISC-5. Phát hiện này khó giải thích, do tỷ lệ nhỏ vị thành niên tìm kiếm dịch vụ ngay từ đầu (6.5%; n = 389). Có thể một phần vị thành niên này nhận được sự giúp đỡ đầy đủ từ các dịch vụ để giảm triệu chứng đến mức không còn được ghi nhận là có vấn đề sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, do DISC-5 đo lường triệu chứng trong 12 tháng qua và do một nửa vị thành niên này chỉ tiếp cận dịch vụ một lần, có vẻ không chắc đây là trường hợp trong tất cả các tình huống. Cũng có thể một số vị thành niên này thực sự có vấn đề sức khỏe tâm thần nhưng không được ghi nhận dựa trên các triệu chứng được đánh giá trong DISC-5 hoặc khái niệm về 'vấn đề cảm xúc và hành vi' không tương quan tốt với vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần như câu hỏi dự định. Hơn nữa, mặc dù đã có mọi nỗ lực để điều chỉnh DISC-5 cho bối cảnh Việt Nam, có thể các thuật toán chấm điểm dựa trên DSM-5 (tức là cách xác định những người có vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc rối loạn tâm thần) cần được xem xét thêm để nắm bắt chính xác các phân bố triệu chứng khác nhau trong quần thể Việt Nam. Dữ liệu do V-NAMHS cung cấp cho phép nghiên cứu như vậy trong các phân tích tương lai.

**Hạn chế (Limitations)**

Các phát hiện của V-NAMHS về sử dụng dịch vụ cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi cần được diễn giải với một số thận trọng. Thứ nhất, số lượng nhỏ vị thành niên tiếp cận dịch vụ cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi (n = 389) khiến việc xác định các mô hình rõ ràng trong sử dụng

dịch vụ (ví dụ: tần suất hoặc sự hiện diện của vấn đề sức khỏe tâm thần) trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các phát hiện này là điểm khởi đầu và, ở mức rộng nhất, chứng minh nhu cầu chưa được đáp ứng và rào cản đối với chăm sóc trong quần thể vị thành niên Việt Nam. Thứ hai, hầu hết câu hỏi được hỏi phụ huynh thay vì vị thành niên do các cân nhắc liên quan đến độ dài tiềm năng của cuộc phỏng vấn. Điều này có nghĩa là quan điểm của vị thành niên, đặc biệt về rào cản đối với chăm sóc, không được đo lường. Tuy nhiên, do hầu hết vị thành niên cho biết nói chuyện với thành viên gia đình khi có lo lắng hoặc quan ngại, vai trò 'người gác cổng' (gatekeeper) của phụ huynh trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe tâm thần cho thấy họ có vị trí tốt để cung cấp thông tin về rào cản đối với chăm sóc có liên quan nhất đến các nhà hoạch định chính sách. Hơn nữa, các câu hỏi về sử dụng dịch vụ được hỏi phụ huynh có thể dễ dàng được điều chỉnh cho người trả lời vị thành niên trong các nghiên cứu tương lai.

**Hàm ý (Implications)**

V-NAMHS phát hiện nhu cầu chưa được đáp ứng tiềm tàng lớn về dịch vụ, với dưới 10% những người có vấn đề sức khỏe tâm thần tiếp cận dịch vụ trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, các phát hiện cũng làm nổi bật cơ hội để cải thiện xu hướng tìm kiếm sự giúp đỡ cho vấn đề sức khỏe tâm thần của vị thành niên và gia đình. Ví dụ, các phát hiện cho thấy phụ huynh và gia đình là nguồn hỗ trợ trung tâm cho vị thành niên. Gần ba phần tư vị thành niên (73.9%) cho biết họ nói chuyện với thành viên gia đình khi có lo lắng hoặc quan ngại. Điều này phù hợp với nghiên cứu trước đây từ Việt Nam cũng phát hiện rằng người trẻ có khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ cho vấn đề sức khỏe tâm thần từ gia đình và bạn bè nhiều nhất (Kamimura et al. 2018, Truc Thanh Thai, Ngoc Ly Ly Thi Vu and Han Hy Thi Bui 2020). Tuy nhiên, trong V-NAMHS, chỉ 5.1% phụ huynh xác định rằng con vị thành niên cần được giúp đỡ cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua mặc dù 21.7% vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần trong cùng kỳ. Trong số đó, hơn một phần ba (37.7%) cho biết con vị thành niên đã nhận được tất cả sự giúp đỡ cần thiết và thêm 20.4% cho biết không tiếp cận sự giúp đỡ vì thích tự xử lý vấn đề của con vị thành niên hoặc với sự giúp đỡ của gia đình. Sự kết hợp dữ liệu phụ huynh và vị thành niên chứng minh rằng các chiến lược được thiết kế cụ thể để cải thiện hiểu biết sức khỏe tâm thần (mental health literacy), giảm kỳ thị liên quan đến sức khỏe tâm thần (mental health-related stigma), và tăng nhận thức về các dịch vụ sẵn có trong các gia đình có thể là bước đi thận trọng. Các chương trình như vậy có thể tập trung vào việc đảm bảo phụ huynh cảm thấy được trang bị tốt hơn để xử lý lo lắng hoặc quan ngại do vị thành niên trình bày, đồng thời giáo dục họ về các dấu hiệu của vấn đề sức khỏe

tâm thần, nơi tìm kiếm sự giúp đỡ cho các vấn đề đó, và lợi ích của việc làm như vậy cho cả con vị thành niên và gia đình nói chung. Có một cơ sở bằng chứng đang phát triển cho việc điều chỉnh các chương trình hiểu biết sức khỏe tâm thần cho Việt Nam (Hoang Minh Dang et al. 2018, Nga Linh La et al. 2022, Thach Tran et al. 2020). Vấn đề hiểu biết sức khỏe tâm thần thấp và kỳ thị đáng kể xung quanh sức khỏe tâm thần tại Việt Nam được chứng minh bởi các nghiên cứu hiện có báo cáo quan điểm từ cả dân số nói chung (Kamimura et al. 2018, Mai Do et al. 2014, Mckelvey et al. 1999, Quynh Chi Nguyen Thai and Thanh Huong Nguyen 2018, Truc Thanh Thai, Ngoc Ly Ly Thi Vu and Han Hy Thi Bui 2020) và các chuyên gia sức khỏe tâm thần (Hoang-Minh Dang et al. 2020), lưu ý rằng bằng chứng cụ thể về vị thành niên và gia đình vẫn còn hạn chế.

Bất kỳ cải thiện nào về hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ của vị thành niên và gia đình cũng phải được đáp ứng bởi các cải thiện tương đương về tính sẵn có của dịch vụ. Một lần nữa, các phát hiện của V-NAMHS làm nổi bật cơ hội cho các bước ban đầu hướng tới những cải thiện như vậy. Ví dụ, trong số những người tiếp cận dịch vụ cho các vấn đề về cảm xúc và hành vi trong 12 tháng qua, hơn một nửa (56.2%) đã tiếp cận từ các nhà cung cấp y tế chính thức hơn như bác sĩ hoặc y tá. Do đó, có thể có cơ hội tích hợp sàng lọc sức khỏe tâm thần (mental health screening) vào các dịch vụ y tế tổng quát hiện có, đồng thời cung cấp giáo dục và đào tạo về sức khỏe tâm thần và các lộ trình chuyển tuyến (referral pathways) cho các bác sĩ đa khoa. Ví dụ, để tạo thuận lợi cho việc tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần vào dịch vụ y tế ban đầu (primary health services), WHO

## Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam (V-NAMHS)

### Trang 31-32 (tiếp theo)

Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố Hướng dẫn Can thiệp mhGAP (mhGAP-IG phiên bản 1.0 công bố năm 2010; phiên bản 2.0 công bố năm 2016) dành cho các rối loạn tâm thần, thần kinh và sử dụng chất gây nghiện tại các cơ sở y tế không chuyên khoa, để sử dụng bởi bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế khác cũng như các nhà hoạch định và quản lý y tế (Tổ chức Y tế Thế giới 2016). Tính khả thi và hữu ích của việc tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần vào các cơ sở y tế ban đầu và cộng đồng đã được chứng minh tại nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (LMICs) (Keynejad, Spagnolo và Thornicroft 2022). Các hướng dẫn mhGAP cung cấp nền tảng

cho việc triển khai các chính sách và thực hành như vậy tại Việt Nam, có thể được sử dụng để tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy các dịch vụ mà vị thành niên và gia đình họ đang tìm kiếm để được hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Việc tích hợp các hoạt động sức khỏe tâm thần vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ giúp tận dụng các phát hiện của V-NAMHS bằng cách cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế chính thức đào tạo và nguồn lực đầy đủ để hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Cần lưu ý rằng bất kỳ nỗ lực nào như vậy đều đòi hỏi sự công nhận các rối loạn tâm thần thông qua các chính sách và chiến lược phù hợp nhằm hướng dẫn cải thiện phân bổ nguồn lực cho sức khỏe tâm thần vị thành niên.

## COVID-19

### Tổng quan

Trường hợp COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2020. Một Ban Chỉ đạo Quốc gia sau đó được thành lập để quản lý phản ứng của Chính phủ đối với đại dịch COVID-19. Chính phủ đã khởi xướng các quy trình cách ly chính thức và các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, bao gồm cấm tụ tập đông người, thực thi hạn chế di chuyển và bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Lệnh phong tỏa toàn quốc được ban hành từ tháng 4 năm 2020, yêu cầu người dân ở nhà, các doanh nghiệp và trường học đóng cửa. Sau lệnh phong tỏa toàn quốc, các lệnh phong tỏa cục bộ ở cấp tỉnh tiếp tục được thực hiện. Việt Nam chứng kiến đỉnh dịch COVID-19 vào tháng 9 năm 2021 với hơn 10,000 ca mắc mới mỗi ngày. Năm 2022, với tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 cao, Chính phủ đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa và cách ly trên toàn quốc (Bộ Y tế 2022, Chính phủ 2022).

Trên toàn cầu, đại dịch COVID-19 đã tác động đến cuộc sống của vị thành niên thông qua việc thực thi các biện pháp kiểm soát (bao gồm đóng cửa trường học) dẫn đến cô lập xã hội, thiếu thói quen sinh hoạt hàng ngày và căng thẳng trong gia đình. Các bằng chứng mới nổi đã cho thấy mối liên hệ giữa đại dịch COVID-19 và tỷ lệ lo âu (anxiety), trầm cảm (depression) và căng thẳng (stress) cao hơn (Jones, Mitra và Bhuiyan 2021). Hiểu được COVID-19 có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần vị thành niên như thế nào là cần thiết cho việc chuẩn bị ứng phó đại dịch trong tương lai và cung cấp sự hỗ trợ mà thanh thiếu niên cần để giải quyết những gì một số người gọi là "thế hệ mất mát" (Hafstad và Augusti 2021). Hiện tại, thiếu dữ liệu đại diện quốc gia từ cả vị thành niên lẫn cha mẹ họ về cách đại dịch COVID-19 đã tác động đến cuộc sống của họ trong bối cảnh sức khỏe tâm thần và sức khỏe tinh thần (wellbeing). Chương này trình bày cách các yếu tố

của đại dịch COVID-19 liên quan nhất đến V-NAMHS được đo lường và báo cáo các phát hiện chính. Tất cả tỷ lệ và số liệu trình bày trong chương này đều được tính có trọng số (weighted). Mặc dù các kiểm định ý nghĩa thống kê (tests of statistical significance) không được đưa vào chương này hay báo cáo nói chung, các sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đã được đánh dấu trong bảng liên quan và chỉ các sự khác biệt có ý nghĩa thống kê mới được thảo luận trong văn bản. Các vấn đề liên quan đến việc diễn giải các phát hiện này và hàm ý của chúng cho các nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh sức khỏe tâm thần sau đó được thảo luận ngắn gọn.

**Đo lường**

Các câu hỏi về COVID-19 tập trung vào các yếu tố có khả năng liên quan nhất đến sức khỏe tâm thần theo mục tiêu cốt lõi của V-NAMHS. Các câu hỏi này không nhằm mục đích cũng không được thiết kế để đo lường toàn diện tất cả các trải nghiệm trong đại dịch COVID-19. Các câu hỏi được thiết kế riêng cho cuộc khảo sát, ban đầu dựa trên việc rà soát tài liệu liên quan và sau đó tham vấn với cả năm nhóm NAMHS quốc tế. Các câu hỏi được đặt cho cả cha mẹ và vị thành niên, liên quan cụ thể đến các trải nghiệm trong thời gian đại dịch.

Cả cha mẹ và vị thành niên đều được hỏi trước tiên liệu họ đã nghe nói về COVID-19 chưa. Những người đã biết sau đó được hỏi một loạt câu hỏi liên quan đến trải nghiệm của họ trong đại dịch COVID-19. Cha mẹ được hỏi về việc tiếp xúc trực tiếp với COVID-19, cách ly (quarantine), kỳ thị (stigma), tác động kinh tế đối với hộ gia đình (bao gồm bất kỳ thay đổi nào về thu nhập hộ gia đình và thiếu tiền cho các nhu cầu thiết yếu), và những thay đổi trong việc sử dụng rượu bia và chất gây nghiện bất hợp pháp của chính họ. Cha mẹ cũng được hỏi về nhu cầu giúp đỡ của vị thành niên đối với các vấn đề cảm xúc hoặc hành vi trong đại dịch COVID-19, liệu họ có sử dụng dịch vụ cho các vấn đề này trong đại dịch không, và những rào cản liên quan đến COVID-19 nào đã ngăn họ tìm kiếm sự giúp đỡ cho vị thành niên của mình (nếu có).

Vị thành niên được hỏi về việc liệu họ có ngừng đi học vĩnh viễn trong đại dịch COVID-19 hay không. Họ cũng được hỏi về các trải nghiệm khác nhau trong đại dịch bao gồm chứng kiến bạo lực giữa người lớn trong hộ gia đình, việc sử dụng rượu bia và chất gây nghiện bất hợp pháp của người lớn trong hộ gia đình, và việc sử dụng rượu bia và chất gây nghiện bất hợp pháp của chính họ. Cuối cùng, vị thành niên được hỏi về sự gia tăng các vấn đề cảm xúc và hành vi cụ thể trong đại dịch COVID-19 và liệu họ có ai để nói chuyện khi gặp các vấn đề này.

**Phát hiện**

Như thể hiện trong Bảng 17, 7.7% vị thành niên "rất đồng ý" rằng họ thường xuyên trải qua ít nhất một vấn đề cảm xúc hoặc hành vi nhiều hơn bình thường trong đại dịch COVID-19, không có sự khác biệt giữa nam và nữ (nếu tính cả những người trả lời "đồng ý", tỷ lệ này sẽ cao tới 67%).

**Bảng 17: Tỷ lệ thường xuyên trải qua các vấn đề cảm xúc và hành vi nhiều hơn bình thường trong đại dịch COVID-19 ở nhóm 10-17 tuổi theo giới tính**

| | Nam | | Nữ | | Tổng | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| | % | n | % | n | % | n |

| Lo âu hoặc căng thẳng hơn (More anxious or stressed) | 5.2 | 162 | 4.9 | 141 | 5.1 | 304 |

| Buồn hơn hoặc trầm cảm hơn (Sadder or more depressed) | 3.6 | 112 | 3.7 | 106 | 3.6 | 218 |

| Khó tập trung hơn (More problems concentrating) | 2.7 | 85 | 1.9 | 55 | 2.3 | 140 |

| Cô đơn hoặc cô lập hơn (More lonely or isolated) | 2.2 | 70 | 1.5 | 42 | 1.9 | 112 |

| Tổng (tăng bất kỳ vấn đề nào) | 8.2 | 254 | 7.3 | 209 | 7.7 | 463 |

*N có trọng số: nam = 3,119; nữ = 2,877*

Tổng cộng 7.1% (n = 427) cha mẹ báo cáo rằng vị thành niên của họ cần được giúp đỡ về các vấn đề cảm xúc và hành vi trong đại dịch COVID-19. Trong số đó, 80.3% (n = 343) không tiếp cận dịch vụ trong đại dịch và phần lớn báo cáo rằng điều này là do sợ nhiễm COVID-19 (69.2%; n = 237), lưu ý rằng cha mẹ có thể chọn nhiều hơn một lý do cho việc không tiếp cận dịch vụ trong thời gian này.

Hình 4 cho thấy tỷ lệ vị thành niên xác nhận các trải nghiệm khác nhau trong đại dịch COVID-19 và tỷ lệ báo cáo rằng đây là sự gia tăng so với trước đại dịch. Trong khi gần 10% vị thành niên báo cáo một người lớn trong hộ gia đình uống rượu hoặc sử dụng chất gây nghiện bất hợp pháp trong đại dịch, chưa đến 1% (0.5%) toàn bộ mẫu vị thành niên báo cáo rằng đây là sự gia tăng so với trước đại dịch. Hơn hai phần ba cha mẹ (71.5%) báo cáo thu nhập hộ gia đình giảm trong đại

dịch COVID-19. Hơn nữa, 12.3% cho biết họ thường xuyên không có đủ tiền cho các nhu cầu thiết yếu trong đại dịch.

**Hình 4. Các trải nghiệm trong đại dịch COVID-19 ở nhóm 10-17 tuổi**

| Trải nghiệm | Trong COVID-19 | Nhiều hơn trước COVID-19 |

|---|---|---|

| Chứng kiến bạo lực giữa người lớn trong hộ gia đình | n = 53 | n = 4 |

| Người lớn trong hộ gia đình sử dụng chất gây nghiện/uống rượu | n = 593 | n = 29 |

| Vị thành niên sử dụng chất gây nghiện/uống rượu | n = 87 | n = 3 |

## Các vấn đề cần xem xét

#### Diễn giải

Cứ mười ba vị thành niên thì có một người (7.7%) báo cáo thường xuyên cảm thấy trầm cảm hơn, lo âu hơn, cô lập hơn, hoặc gặp nhiều khó khăn trong tập trung hơn trong đại dịch COVID-19 so với trước đại dịch. Những phát hiện này nhìn chung nhất quán với các nghiên cứu khác được thực hiện tại Việt Nam. Ví dụ, một đánh giá nhanh định tính về tác động của COVID-19 tại Việt Nam do UNICEF thực hiện đã tìm thấy mối liên hệ giữa COVID-19 và mức độ căng thẳng, lo âu và trầm cảm tăng cao được thanh thiếu niên báo cáo theo dạng giai thoại (UNICEF 2020a). Tuy nhiên, việc so sánh rất khó khăn vì có rất ít nghiên cứu định lượng về tác động của COVID-19 tại Việt Nam, và không có nghiên cứu nào được thực hiện trên quy mô lớn hơn. Hơn nữa, trong khi 7.1% cha mẹ báo cáo rằng vị thành niên của họ cần được giúp đỡ về các vấn đề cảm xúc và hành vi trong đại dịch COVID-19, 80.3% trong số đó báo cáo rằng họ không sử dụng dịch vụ. Điều này chủ yếu do sợ nhiễm COVID-19 (69.2%). Các nghiên cứu tương tự được thực hiện ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình khác cũng báo cáo rằng một tỷ lệ đáng kể vị thành niên và thanh niên cảm thấy họ cần được giúp đỡ liên quan đến sức khỏe thể chất và tâm thần trong đại dịch COVID-19 nhưng không yêu cầu giúp đỡ (UNICEF 2020b).

#### Hạn chế

Mặc dù V-NAMHS cung cấp một cơ hội quý để đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với sức khỏe tâm thần và sức khỏe tinh thần của vị thành niên, nghiên cứu không được thiết kế

cũng không nhằm mục đích đo lường toàn diện tất cả các khía cạnh của đại dịch COVID-19. Thay vào đó, các câu hỏi được thiết kế để cung cấp một "bức tranh tổng quát" ngắn gọn về đại dịch COVID-19 trong bối cảnh V-NAMHS và tạo cơ hội cho phân tích trong tương lai có tính đến bất kỳ tác động nào của đại dịch. Do đó, vẫn có khả năng một số khía cạnh liên quan của giai đoạn đại dịch không được ghi nhận. Hơn nữa, ban đầu có lo ngại rằng nỗi sợ nhiễm COVID-19 có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ phản hồi của V-NAMHS và có khả năng làm sai lệch các phát hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ phản hồi cuối cùng là 81.1% cho thấy đây không phải là vấn đề.

#### Hàm ý

Các phát hiện của V-NAMHS đã chứng minh rằng đại dịch COVID-19 có tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của vị thành niên tại Việt Nam. Những phát hiện này, kết hợp với những phát hiện cho thấy nhu cầu chưa được đáp ứng về dịch vụ sức khỏe tâm thần, cho thấy cần cải thiện các chính sách và dịch vụ hỗ trợ vị thành niên cả hiện tại, trong tương lai và trong việc chuẩn bị cho các đại dịch/tình huống khủng hoảng trong tương lai. Ví dụ, các dịch vụ dễ tiếp cận (như đường dây điện thoại hoặc dịch vụ trò chuyện trực tuyến) có thể là một cách tiếp cận thận trọng để giải quyết nhu cầu chưa được đáp ứng tiềm ẩn lớn về dịch vụ, đồng thời đảm bảo rằng chăm sóc khủng hoảng và tính liên tục của chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện có có thể được đảm bảo trong các tình huống bất ngờ. Trong các tình huống này, nâng cao sức khỏe có mục tiêu cũng có thể hữu ích để hướng đến vị thành niên phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần liên quan đến các yếu tố gây căng thẳng cụ thể, ví dụ: sự cô đơn và trầm cảm liên quan đến đóng cửa trường học. Vị thành niên cần tiếp cận dịch vụ lần đầu tiên có thể đặc biệt dễ bị tổn thương, và các thông điệp y tế công cộng cung cấp kiến thức, giảm kỳ thị và bình thường hóa sức khỏe tâm thần có thể có tầm quan trọng đặc biệt. Hơn nữa, sự gia tăng được báo cáo về các vấn đề cảm xúc và hành vi trong đại dịch COVID-19 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa sức khỏe tâm thần vào kế hoạch cho các sự kiện cấp dân số trong tương lai như đại dịch, thiên tai và xung đột.

## Phụ lục 1: Các công cụ đo lường (Measures)

Các công cụ đo lường được thực hiện với cha mẹ và vị thành niên được trình bày dưới đây. Thông tin này được điều chỉnh từ Erskine và cộng sự (2021).

### Cha mẹ (Parent)

| Công cụ đo lường | Mô tả |

|---|---|

| Thông tin nhân khẩu học (Demographics) | Thu thập thông tin nhân khẩu học liên quan đến hộ gia đình, vị thành niên và cha mẹ. Tính đủ điều kiện tham gia cũng được đánh giá trong phần này theo các tiêu chí loại trừ được nêu chi tiết trong phần Giới thiệu dưới mục 'Ai đã tham gia V-NAMHS'? |

| Bệnh mạn tính (Chronic illness) | Đo lường bệnh nghiêm trọng hoặc mạn tính mà vị thành niên hoặc người chăm sóc gặp phải. |

| Bảng kiểm triệu chứng Nhi khoa – 17 (PSC-17) (Pediatric Symptom Checklist – 17) | Bảng câu hỏi sàng lọc ngắn đánh giá các triệu chứng hướng nội (internalising) và hướng ngoại (externalising) ở vị thành niên, được sử dụng để đo lường quan điểm của cha mẹ về sức khỏe tâm thần của vị thành niên. |

| Bảng hỏi Sức khỏe Bệnh nhân – 9 (PHQ-9) (Patient Health Questionnaire – 9) | Công cụ sàng lọc ngắn được sử dụng để sàng lọc triệu chứng trầm cảm (depressive symptomology) của cha mẹ. |

| Rối loạn Lo âu Tổng quát – 7 (GAD-7) (Generalised Anxiety Disorder – 7) | Công cụ sàng lọc ngắn được sử dụng để sàng lọc triệu chứng lo âu (anxious symptomology) của cha mẹ. |

| DISC-5: Phần giới thiệu (Introductory module) | Thiết lập dòng thời gian của các sự kiện quan trọng trong 12 tháng qua để hỗ trợ người tham gia nhớ lại và hướng dẫn người tham gia cách trả lời các câu hỏi trong các phần DISC-5. |

| DISC-5: ADHD (Rối loạn Tăng động Giảm chú ý) | Đo lường tỷ lệ hiện mắc (prevalence) ADHD trong 12 tháng qua. |

| Sử dụng dịch vụ (Service use) | Thu thập thông tin từ cha mẹ về việc sử dụng dịch vụ, rào cản tiếp cận dịch vụ chăm sóc, và nhu cầu được nhận thức về dịch vụ chăm sóc liên quan đến vị thành niên. |

| COVID-19 | Đo lường tiếp xúc trực tiếp với COVID-19, kỳ thị (stigma), tác động kinh tế đối với hộ gia đình, sử dụng chất gây nghiện của cha mẹ, và việc sử dụng dịch vụ của vị thành niên trong đại dịch COVID-19. |

## Vị thành niên (Adolescent)

| Công cụ đo lường | Mô tả |

|---|---|

| DISC-5: Phần giới thiệu (Introductory module) | Thiết lập dòng thời gian của các sự kiện quan trọng trong 12 tháng qua để hỗ trợ người tham gia nhớ lại và hướng dẫn người tham gia cách trả lời các câu hỏi trong các phần DISC-5. |

| DISC-5: Ám sợ xã hội (Social phobia) | Đo lường tỷ lệ hiện mắc ám sợ xã hội (social phobia) trong 12 tháng qua. |

| DISC-5: Rối loạn lo âu tổng quát (Generalised anxiety disorder) | Đo lường tỷ lệ hiện mắc rối loạn lo âu tổng quát (generalised anxiety disorder) trong 12 tháng qua. |

| DISC-5: Rối loạn trầm cảm chủ yếu (Major depressive disorder) | Đo lường tỷ lệ hiện mắc rối loạn trầm cảm chủ yếu (major depressive disorder) trong 12 tháng qua. Bao gồm các câu hỏi về hành vi tự tử (suicidal behaviour) được hỏi tất cả vị thành niên. |

| Tự gây thương tích (Self-harm) | Đo lường tỷ lệ hiện mắc, tuổi khởi phát và thời gian gần nhất của tự gây thương tích (self-harm). |

| DISC-5: Rối loạn hành vi (Conduct disorder) | Đo lường tỷ lệ hiện mắc rối loạn hành vi (conduct disorder) trong 12 tháng qua. |

| DISC-5: Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) (Posttraumatic stress disorder) | Đo lường tỷ lệ hiện mắc PTSD trong 12 tháng qua. |

| Hỗ trợ không chính thức và chiến lược tự giúp (Informal help and self-help strategies) | Thu thập thông tin về hỗ trợ không chính thức và chiến lược tự giúp. |

| Sức khỏe tự đánh giá và hình ảnh cơ thể (Self-rated health and body image) | Đo lường sức khỏe tự đánh giá và hình ảnh cơ thể của vị thành niên. |

| Hoạt động thể chất (Physical activity) | Đo lường hoạt động thể chất của vị thành niên. |

| Thang đo Lòng tự trọng Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale) | Công cụ chuẩn hóa ngắn đo lường lòng tự trọng (self-esteem). |

| Bắt nạt (Bullying) | Đo lường tần suất bị bắt nạt (bullying victimisation) và thực hiện bắt nạt (bullying perpetration), bao gồm hình thức bắt nạt. |

| Trường học và giáo dục (School and education) | Đo lường nguyện vọng học tập (cả hiện tại và quá khứ tùy thuộc vào tình trạng đi học hiện tại), kỳ vọng và áp lực. |

| Quan hệ bạn bè và sự cô đơn (Peer relationships and loneliness) | Thu thập thông tin về tình bạn của vị thành niên (bao gồm sự lệch lạc của bạn bè - peer deviance) và sự cô đơn. |

| Sự gắn kết gia đình GEAS (GEAS Family Connectedness) | Thu thập thông tin về mối quan hệ của vị thành niên với cha mẹ. |

| Tín ngưỡng (Religiosity) | Đo lường sự hỗ trợ nhận được từ cộng đồng tín ngưỡng. |

| An toàn và an ninh (Safety and security) | Đo lường cảm nhận về an toàn cá nhân trong các bối cảnh khác nhau, ví dụ: nhà, trường học và khu dân cư. |

| Hành vi tình dục (Sexual behaviour)* | Thu thập thông tin về hành vi tình dục, xu hướng tính dục và bản dạng giới (gender identity) của vị thành niên. Chỉ hỏi vị thành niên từ 12-17 tuổi. |

| Bảng hỏi Trải nghiệm Bất lợi Thời thơ ấu (ACEs) (Adverse Childhood Experiences questionnaire)* | Đo lường phơi nhiễm suốt đời với nhiều loại lạm dụng, bỏ mặc, bạo lực giữa cha mẹ hoặc người chăm sóc, các dạng rối loạn chức năng nghiêm trọng khác trong hộ gia đình và bạo lực. |

| Sử dụng chất gây nghiện (Substance use)* | Đo lường việc sử dụng thuốc lá, rượu bia, cần sa (cannabis) và các chất gây nghiện bất hợp pháp khác. |

| COVID-19 | Đo lường tiếp xúc trực tiếp với COVID-19, tác động giáo dục, bất lợi hộ gia đình/cá nhân, và các vấn đề cảm xúc và hành vi trong đại dịch COVID-19. |

** Các phần này do vị thành niên tự thực hiện.*

## Phụ lục 2: Phương pháp nghiên cứu (Methodology)

### Khung mẫu (Sampling frame)

Mục tiêu chính của khung mẫu cho V-NAMHS là cung cấp các ước tính đáng tin cậy về mặt thống kê về tỷ lệ hiện mắc các rối loạn tâm thần ở vị thành niên. Mẫu có tính đại diện quốc gia, bao gồm cả khu vực thành thị và nông thôn.

Khung mẫu V-NAMHS bao gồm tất cả 63 tỉnh/thành phố, gồm 713 quận/huyện, được chia thành bốn vùng (Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; và Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long).

**Bảng 18. Dân số Việt Nam năm 2019 theo vùng và khu vực nông thôn-thành thị**

| Vùng | Dân số (người) | % tổng dân số | Khu vực thành thị - Dân số (người) | % tổng dân số |

|---|---|---|---|---|

| Vùng 1: Trung du miền núi phía Bắc + Tây Nguyên | 18,375,547 | 19.1 | 3,957,095 | 21.5 |

| Vùng 2: Đồng bằng sông Hồng | 22,543,607 | 23.4 | 7,856,566 | 34.9 |

| Vùng 3: Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 20,187,293 | 21.0 | 5,719,511 | 28.3 |

| Vùng 4: Đông Nam Bộ + Đồng bằng sông Cửu Long | 35,102,537 | 36.5 | 15,526,563 | 44.2 |

| Tổng | 96,208,984 | 100.0 | 33,059,735 | 34.4 |

*Nguồn: (Tổng cục Thống kê 2020)*

Tổng cộng, 38 tỉnh/thành phố từ bốn vùng đã được chọn cho cuộc khảo sát (xem bản đồ ở Hình 5), bao gồm:

- **Vùng 1**: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Điện Biên, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

- **Vùng 2**: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định.

- **Vùng 3**: Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận.

- **Vùng 4**: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu.

Các hộ gia đình tại 38 tỉnh được chọn được nhóm thành các đơn vị điều tra gọi là Địa bàn Điều tra (Enumeration Areas - EAs), với trung bình khoảng 120 hộ gia đình mỗi EA. Sau đó 200 EA được chọn ngẫu nhiên từ 38 tỉnh được chọn với phân bổ đều cho bốn vùng, tức 50 EA mỗi vùng (25 EA thành thị và 25 EA nông thôn). Số hộ gia đình được chọn cho mỗi EA trong V-NAMHS là 38 hộ mỗi EA. Tỷ lệ phản hồi ước tính 79% (tỷ lệ không phản hồi = 21%) đã được áp dụng khi tính cỡ mẫu V-NAMHS. Việc chọn 7600 hộ gia đình tương ứng với số lượng dự kiến 6000 hộ gia đình hoàn thành phỏng vấn.

*Ghi chú: Các tỉnh/thành phố được chọn được đánh dấu trên bản đồ*

*Nguồn: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam & V-NAMHS*

**Hình 5. Bản đồ Việt Nam và 38 tỉnh/thành phố được chọn**

**Nghiên cứu thí điểm (Pilot study)**

Trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu cho V-NAMHS, một nghiên cứu thí điểm đã được tiến hành để kiểm tra tất cả các quy trình và logistics. Nghiên cứu thí điểm được thực hiện tại Hà Nội ở miền Bắc và Đồng Nai ở miền Nam. Tại Hà Nội, 25 vị thành niên (9 nam và 16 nữ) và cha mẹ họ đã được phỏng vấn. Tại Đồng Nai, thêm 25 vị thành niên (12 nam và 13 nữ) và cha mẹ họ đã được phỏng vấn. Nghiên cứu thí điểm được tiến hành để kiểm tra tính nhất quán và mạch lạc của các câu hỏi nghiên cứu, thời gian phỏng vấn, tính phù hợp của ngôn ngữ, và việc thực hiện các câu hỏi khó hoặc nhạy cảm. Nghiên cứu thí điểm cũng được sử dụng để kiểm tra mức độ hoạt

động tốt của các công cụ được lập trình trên nền tảng SurveyCTO cũng như để hỗ trợ lập kế hoạch và tổ chức khảo sát. Phần lớn các thách thức liên quan đến độ dài của công cụ, khó khăn trong hiểu biết đối với vị thành niên nhỏ tuổi hơn, và các vấn đề lập trình. Các thách thức này đã được xem xét và các sửa đổi cần thiết đã được thực hiện cho công cụ trước khi thu thập dữ liệu.

**Công tác thực địa (Fieldwork)**

Thu thập dữ liệu tại Việt Nam bắt đầu vào ngày 21 tháng 9 năm 2022, bắt đầu từ miền Bắc rồi đến miền Nam. Thu thập dữ liệu có sự tham gia của tổng cộng 127 điều tra viên. Công tác thực địa được triển khai theo quy trình thực địa được xây dựng và thiết lập bởi cả năm nhóm NAMHS quốc tế, sau đó được áp dụng tại Việt Nam. Nhóm V-NAMHS đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (GOPFP) để xác định ranh giới trong quá trình lập danh sách hộ gia đình và lập bản đồ tại 38 tỉnh. Tổng cộng 200 EA được chọn, mỗi EA chứa khoảng 120 hộ gia đình, trong đó 38 hộ được chọn cho mẫu V-NAMHS. Do các hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19 giữa các tỉnh ở Việt Nam trong quá trình thu thập dữ liệu, các điều tra viên là nhân viên của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình địa phương (POPFP), giúp tránh việc điều tra viên phải di chuyển giữa các tỉnh. Số lượng điều tra viên phân bổ cho mỗi tỉnh phụ thuộc vào quy mô tỉnh và dao động từ 2 đến 16 điều tra viên. Thu thập dữ liệu chỉ được thực hiện nếu EA được chọn được phân loại là "xanh" (an toàn) hoặc "vàng" (nguy cơ thấp COVID-19) và bị tạm dừng nếu EA được phân loại là "cam" (nguy cơ cao) hoặc "đỏ" (nguy cơ rất cao).

Trong những tuần trước khi thu thập dữ liệu, các thư chứa thông tin về V-NAMHS được cung cấp cho các hộ gia đình được chọn trong mỗi EA. Các quy trình đảm bảo sự tham gia tự nguyện của cha mẹ và vị thành niên, quyền riêng tư, an toàn (cho điều tra viên và người tham gia), và bảo mật dữ liệu cũng được đưa vào thông tin cung cấp cho các hộ gia đình. Điều này được tạo thuận lợi bởi sự hợp tác chặt chẽ giữa nhóm V-NAMHS, GOPFP và các POPFP.

Trong suốt quá trình thu thập dữ liệu, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho nhân viên thực địa hàng ngày bởi nhóm V-NAMHS qua giao tiếp trực tuyến. Nhóm V-NAMHS cũng phối hợp với các nhóm UQ và JHSPH, những người giám sát dữ liệu theo các quy trình đã được xác định trước. Tư vấn kỹ thuật liên tục và xử lý sự cố cũng được các nhóm này cung cấp.

## Phụ lục 3: Bảng thuật ngữ (Glossary)

| Thuật ngữ | Định nghĩa |

|---|---|

| **Tỷ lệ hiện mắc 12 tháng (12-month prevalence)** | Đáp ứng tiêu chí cho một vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc rối loạn tâm thần theo DISC-5 trong 12 tháng trước phỏng vấn. Bao gồm những người có triệu chứng phát triển lần đầu trong 12 tháng trước phỏng vấn, và những người có triệu chứng phát triển sớm hơn nhưng tiếp tục đáp ứng tiêu chí trong 12 tháng qua. |

| **Vị thành niên (Adolescent)** | Một thanh thiếu niên từ 10-17 tuổi. Mặc dù WHO định nghĩa vị thành niên là những người từ 10-19 tuổi, vị thành niên 18-19 tuổi bị loại khỏi nghiên cứu vì họ có nhiều khả năng sống độc lập và/hoặc làm việc xa nhà hơn. Hơn nữa, các công cụ chẩn đoán (như DISC-5) không được thiết kế để thực hiện cho người từ 18 tuổi trở lên, những người thường được đánh giá bằng các công cụ dành cho người trưởng thành trong các khảo sát tập trung vào người trưởng thành. |

| **Các rối loạn lo âu (Anxiety disorders)** | Một nhóm rối loạn tâm thần được định nghĩa bởi sự sợ hãi và lo âu quá mức. Ám sợ xã hội (social phobia) và rối loạn lo âu tổng quát (generalised anxiety disorder) là hai rối loạn lo âu được đưa vào khảo sát này. |

| **Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) (Attention-deficit/hyperactivity disorder)** | Đặc trưng bởi các kiểu mẫu dai dẳng của sự thiếu chú ý và/hoặc tăng động-bốc đồng (hyperactivity-impulsivity). Vị thành niên có thể gặp khó khăn với sự chú ý và tập trung, có chuyển động quá mức và/hoặc khó kiểm soát các hành vi bốc đồng. Các hành vi này không phù hợp với tuổi hoặc mức phát triển của vị thành niên và xảy ra ở nhiều bối cảnh khác nhau. Phần DISC-5 ADHD được thực hiện với cha mẹ. |

| **Rối loạn hành vi (Conduct disorder)** | Đặc trưng bởi một kiểu mẫu hành vi lặp đi lặp lại vi phạm quyền của người khác và/hoặc các quy tắc hoặc chuẩn mực xã hội quan trọng. Các hành vi có thể bao gồm gây hấn với người hoặc động vật, phá hoại tài sản, lừa dối hoặc trộm cắp, hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc. Phần DISC-5 rối loạn hành vi được thực hiện với vị thành niên. |

| **Tiêu chí chẩn đoán (Diagnostic criteria)** | Một tập hợp các yêu cầu cụ thể mà vị thành niên phải đáp ứng để được coi là có rối loạn tâm thần. Tiêu chí có thể bao gồm: một số lượng hoặc sự kết hợp triệu chứng nhất định; tuổi khởi phát của triệu chứng hoặc hành vi; tần suất và thời gian của triệu chứng; đau khổ (distress) hoặc suy giảm chức năng (impairment). Trong V-NAMHS, tiêu chí chẩn đoán được xác định theo DSM-5 (xem bên dưới). |

| **Phỏng vấn Chẩn đoán cho Trẻ em, Phiên bản 5 (DISC-5) (Diagnostic Interview Schedule for Children, Version 5)** | Một công cụ chẩn đoán có cấu trúc hoàn chỉnh được thiết kế để xác định trẻ em hoặc vị thành niên đáp ứng tiêu chí chẩn đoán DSM-5 cho rối loạn tâm thần. Sáu phần chẩn đoán từ DISC-5 được đưa vào khảo sát và được điều chỉnh để đảm bảo phù hợp văn hóa trong khi duy trì tính nhất quán về mặt khái niệm. |

| **Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần, Ấn bản thứ Năm (DSM-5) (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition)** | Định nghĩa các rối loạn tâm thần cá nhân do Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ (American Psychiatric Association) công bố và được sử dụng để định nghĩa và chẩn đoán các rối loạn tâm thần. |

| **Triệu chứng đạt ngưỡng đầy đủ (Full threshold symptoms)** | Xác nhận tất cả các triệu chứng cần thiết để đáp ứng tiêu chí chẩn đoán DSM-5 cho rối loạn tâm thần (lưu ý rằng suy giảm chức năng cũng phải được xác nhận để đáp ứng tiêu chí cho rối loạn tâm thần theo DSM-5). |

| **Rối loạn lo âu tổng quát (Generalised anxiety disorder)** | Đặc trưng bởi sự lo âu và lo lắng quá mức về nhiều sự kiện hoặc hoạt động. Cường độ, tần suất và thời gian của lo âu và lo lắng không tương xứng với khả năng hoặc tác động thực tế của sự kiện dự kiến. Phần DISC-5 rối loạn lo âu tổng quát được thực hiện với vị thành niên. |

| **Suy giảm chức năng (Impairment)** | Khi các triệu chứng của rối loạn tâm thần tác động tiêu cực hoặc can thiệp vào hoạt động chức năng và/hoặc các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của vị thành niên. Xác nhận suy giảm chức năng là cần thiết để đáp ứng tiêu chí chẩn đoán DSM-5 cho rối loạn tâm thần (cùng với xác nhận tất cả các triệu chứng cần thiết, tức là triệu chứng đạt ngưỡng đầy đủ). |

| **Các lĩnh vực suy giảm chức năng (Impairment domains)** | Trong DISC-5, suy giảm chức năng được đánh giá bằng sáu câu hỏi đo lường suy giảm do triệu chứng gây ra trên bốn lĩnh vực: gia đình (vấn đề trong mối quan hệ với người chăm sóc, khó khăn khi dành thời gian với gia đình), bạn bè (khó khăn khi dành thời gian với bạn bè), trường học hoặc công việc (khó khăn với trường học hoặc công việc), và đau khổ cá nhân (personal distress). |

| **Rối loạn trầm cảm chủ yếu (Major depressive disorder)** | Đặc trưng bởi một giai đoạn ít nhất hai tuần trong đó có tâm trạng trầm cảm, mất hứng thú hoặc niềm vui trong hầu hết các hoạt động, và/hoặc cáu kỉnh. Những cảm giác này cũng liên quan đến các triệu chứng thể chất khác như mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ hoặc vấn đề tập trung. Phần DISC-5 rối loạn trầm cảm chủ yếu được thực hiện với vị thành niên. |

| **Rối loạn tâm thần (Mental disorder)** | Một rối loạn tâm thần là một hội chứng hoặc kiểu mẫu hành vi hoặc tâm lý có ý nghĩa lâm sàng xảy ra ở một cá nhân và liên quan đến đau khổ hiện tại (ví dụ: một triệu chứng đau đớn), khuyết tật (tức là suy giảm trong một hoặc nhiều lĩnh vực chức năng quan trọng), và/hoặc nguy cơ tăng đáng kể về tử vong, đau đớn, khuyết tật, hoặc mất tự do quan trọng. Cho mục đích của báo cáo này, vị thành niên có rối loạn tâm thần là những người đáp ứng tiêu chí chẩn đoán DSM-5 cho một rối loạn tâm thần cụ thể (tức là một rối loạn tâm thần được đo lường trong V-NAMHS). |

| **Vấn đề sức khỏe tâm thần (Mental health problem)** | Một vấn đề sức khỏe tâm thần tương tự rối loạn tâm thần ở chỗ nó cũng can thiệp vào cách một người suy nghĩ, cảm nhận và hành xử, nhưng ở mức độ thấp hơn rối loạn tâm thần. Chúng có thể được trải nghiệm tạm thời, hoặc như một phản ứng cấp tính đối với các căng thẳng của cuộc sống. Cho mục đích của báo cáo này, vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần bao gồm những người đáp ứng chẩn đoán rối loạn tâm thần DSM-5 (tức là triệu chứng đạt ngưỡng đầy đủ và xác nhận suy giảm chức năng) cũng như những người không xác nhận suy giảm chức năng (tức là triệu chứng đạt ngưỡng đầy đủ nhưng không suy giảm chức năng) và những người đáp ứng ít nhất một nửa số triệu chứng theo yêu cầu của DSM-5 (tức là triệu chứng dưới ngưỡng - subthreshold symptoms) có hoặc không có suy giảm chức năng. |

| **Cha mẹ (Parent)** | Cho mục đích của báo cáo này, được sử dụng để chỉ người được chỉ định là người chăm sóc chính (primary caregiver) của vị thành niên. Xem "Người chăm sóc chính". |

| **Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) (Posttraumatic stress disorder)** | Đặc trưng bởi những suy nghĩ xâm nhập hoặc tái diễn, phân ly (dissociation), nhận thức bị bóp méo hoặc tiêu cực, tăng kích thích hoặc phản ứng hoặc các triệu chứng xâm nhập khác hoặc phản ứng thể chất, tất cả đều liên quan đến một chấn thương (trauma) cụ thể. Phần DISC-5 PTSD được thực hiện với vị thành niên. |

| **Người chăm sóc chính (Primary caregiver)** | Người có trách nhiệm, chăm sóc và có khả năng cung cấp thông tin tốt nhất về vị thành niên. Người chăm sóc chính này tự xác định ở đầu cuộc phỏng vấn sau khi được đọc định nghĩa trên. Điều này được thực hiện trước khi bắt đầu thực hiện các công cụ đo lường khảo sát. Cho mục đích của báo cáo này, người chăm sóc chính được gọi là cha mẹ. |

| **Tự gây thương tích (Self-harm)** | Tự gây thương tích là hành động cố ý làm tổn hại hoặc gây thương tích cho bản thân, không có ý định kết thúc cuộc sống của mình. Điều này phân biệt tự gây thương tích với nỗ lực tự tử (suicide attempt). |

| **Dịch vụ (Service)** | Trong khảo sát này, dịch vụ được xem là bất kỳ nhà cung cấp nào cung cấp hỗ trợ hoặc tư vấn cho các vấn đề cảm xúc và hành vi. Các nhà cung cấp dịch vụ trong khảo sát này bao gồm: Bác sĩ hoặc điều dưỡng; Chuyên gia (như nhà tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần); Nhân viên y tế cộng đồng; Nhân viên trường học (như giáo viên, huấn luyện viên, hoặc tư vấn viên trường học); Lãnh đạo tôn giáo/tín ngưỡng; Thầy lang/người chữa bệnh truyền thống; Khác (theo định nghĩa của người tham gia). Định nghĩa nhà cung cấp dịch vụ được mở rộng để bao gồm cả những người thường không được coi là nhà cung cấp, do khả năng dự kiến rằng các lĩnh vực này sẽ được tiếp cận cho các dịch vụ như vậy. |

| **Sử dụng dịch vụ (Service use)** | Được định nghĩa là sử dụng bất kỳ dịch vụ nào (bởi các nhà cung cấp được liệt kê ở trên) cho hỗ trợ hoặc tư vấn về các vấn đề cảm xúc và hành vi. Các câu hỏi về sử dụng dịch vụ được hỏi cha mẹ. |

| **Ám sợ xã hội (Social phobia)** | Đặc trưng bởi nỗi sợ một hoặc nhiều tình huống xã hội, trong đó vị thành niên là tâm điểm chú ý của người khác, có thể gây ra cảm giác xấu hổ và nhục nhã. Điều này có thể dẫn đến việc vị thành niên tránh các tình huống này hoặc chịu đựng chúng nhưng rất sợ hãi khi làm vậy. Ở vị thành niên, các tình huống gây lo âu phải ở trong bối cảnh bạn bè, không chỉ xung quanh người lớn. Phần DISC-5 ám sợ xã hội được thực hiện với vị thành niên. |

| **Triệu chứng dưới ngưỡng (Subthreshold symptoms)** | Trong DISC-5, một vị thành niên được coi là có triệu chứng dưới ngưỡng nếu họ xác nhận ít nhất một nửa các triệu chứng theo yêu cầu của DSM-5 nhưng không phải tất cả. |

| **Hành vi tự tử (Suicidal behaviours)** | Bao gồm ý tưởng tự tử (suicidal ideation), lập kế hoạch tự tử (suicide planning) và nỗ lực tự tử (suicide attempt). |

| **Ý tưởng tự tử (Suicidal ideation)** | Suy nghĩ về việc muốn chết hoặc những suy nghĩ chung về việc kết thúc cuộc sống của chính mình. |

| **Nỗ lực tự tử (Suicide attempt)** | Tự gây hại bản thân với ý định kết thúc cuộc sống của chính mình. |

| **Lập kế hoạch tự tử (Suicide planning)** | Lập kế hoạch để kết thúc cuộc sống của chính mình. |

## Phụ lục 4: Các nhóm nghiên cứu (Research teams)

### Nhóm V-NAMHS

| Tên | Vai trò |

|---|---|

| PGS. Vũ Mạnh Lợi | Nghiên cứu viên chính V-NAMHS (V-NAMHS Principal Investigator) |

| PGS. Nguyễn Đức Vinh | Giám đốc Dự án V-NAMHS (V-NAMHS Project Director) |

| Đào Thị Khánh Hòa | Nghiên cứu viên cao cấp V-NAMHS (V-NAMHS Senior Research Officer) |

| GS. Đặng Nguyên Anh | Nghiên cứu viên cao cấp V-NAMHS (V-NAMHS Senior Research Officer) |

| TS. Nghiêm Thị Thủy | Quản lý hành chính V-NAMHS (V-NAMHS Administrator) |

| PGS. Nguyễn Đức Chiến | Nghiên cứu viên V-NAMHS (V-NAMHS Research Officer) |

| TS. Hoàng Vũ Linh Chi | Nghiên cứu viên V-NAMHS (V-NAMHS Research Officer) |

| Khuất Thị Diệu Linh | Nghiên cứu viên V-NAMHS (V-NAMHS Research Officer) |

| Trần Việt Long | Nghiên cứu viên V-NAMHS (V-NAMHS Research Officer) |

| Nguyễn Thị Xuân | Nghiên cứu viên V-NAMHS (V-NAMHS Research Officer) |

| Nguyễn Quang Tuấn | Nghiên cứu viên V-NAMHS (V-NAMHS Research Officer) |

### Nhóm GOPFP (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình)

| Tên | Vai trò |

|---|---|

| TS. Phạm Vũ Hoàng | Trưởng nhóm GOPFP (GOPFP Team Leader) |

| Nguyễn Cao Trường | Quản lý công tác thực địa (Fieldwork Administrator) |

### Đại học Queensland (The University of Queensland)

| Tên | Vai trò |

|---|---|

| TS. Holly Erskine | Nghiên cứu viên chính NAMHS (NAMHS Principal Investigator) |

| GS. Harvey Whiteford | Cố vấn cao cấp NAMHS (NAMHS Senior Advisor) |

| GS. James Scott | Cố vấn lâm sàng NAMHS (NAMHS Clinical Advisor) |

| TS. Sarah Blondell | Nghiên cứu viên cao cấp NAMHS (NAMHS Senior Research Officer) |

| Krystina Wallis | Nghiên cứu viên NAMHS (NAMHS Research Officer) |

| Cartiah McGrath | Nghiên cứu viên NAMHS (NAMHS Research Officer) |

### Trường Y tế Công cộng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)

| Tên | Vai trò |

|---|---|

| GS. Robert Blum | Trưởng dự án NAMHS JHSPH (JHSPH NAMHS Project Lead) |

| TS. Shoshanna Fine | Nhà khoa học trợ lý NAMHS JHSPH (JHSPH NAMHS Assistant Scientist) |

| Mengmeng Li | Nhà phân tích dữ liệu NAMHS JHSPH (JHSPH NAMHS Data Analyst) |

| Astha Ramaiya | Nhà khoa học trợ lý NAMHS JHSPH (JHSPH NAMHS Assistant Scientist) |

## Tài liệu tham khảo (References)

American Psychiatric Association. 2013. "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition, Dsm-5" Washington DC.: American Psychiatric Publishing.

Bitsko, R., H.R. Adams, J. Holbrook, A. Vierhile, P. Morrison and P.W. Fisher. 2019. "2.50 Diagnostic Interview Schedule for Children, Version 5 (Disc-5): Development and Validation of Adhd and Tic Disorder Modules" Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 58(10): Supplement. (https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(19)31599-0/fulltext).

Blum, R., M. Sudhinaraset and M.R. Emerson. 2012. "Youth at Risk: Suicidal Thoughts and Attempts in Vietnam, China, and Taiwan" Journal of Adolescent Health 50(3):537-44. (Doi: https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.12.006).

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2022a. "Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 2022 ban hành Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025." Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2022b. "Quyết định số 1442/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2022 ban hành Chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025 Của Ngành Giáo Dục." Hà Nội.

Bộ Y tế. 2022. Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29 tháng 4 năm 2022 về việc Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa (Official Letter No. 2213/BYT-DP dated April 29, 2022 on the Suspension of Application of Domestic Medical Declaration). Hà Nội.

Canino, G. and M. Alegria. 2008. "Psychiatric Diagnosis - Is It Universal or Relative to Culture?" Journal of Child Psychology and Psychiatry 49(3):237-50. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18333929/).

Cao Tiến Đức. 2020. "Sức khỏe tâm thần: thực trạng, thách thức và những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị" Tạp chí Nội khoa Việt Nam (19):15-20. (https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/wp-content/uploads/2021/05/b2-15-20.pdf).

Chính phủ. 2022. "Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 Năm 2022 ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19." Hà Nội.

Colizzi, M., A. Lasalvia and M. Ruggeri. 2020. "Prevention and Early Intervention in Youth Mental Health: Is It Time for a Multidisciplinary and Trans-Diagnostic Model for Care?" International Journal of Mental Health Systems. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32226481/).

COVID-19 Mental Disorders Collaborators. 2021. "Global Prevalence and Burden of Depressive and Anxiety Disorders in 204 Countries and Territories in 2020 Due to the Covid-19 Pandemic" The Lancet 398(10312):1700-12. (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02143-7/fulltext).

Demyttenaere, K., R. Bruffaerts, J. Posada-Villa, I. Gasquet, V. Kovess, J.P. Lepine, M.C. Angermeyer, S. Bernert, G. de Girolamo, P. Morosini, G. Polidori, T. Kikkawa, N. Kawakami, Y. Ono, T. Takeshima, H. Uda, E.G. Karam, J.A. Fayyad, A.N. Karam, Z.N. Mneimneh, M.E. Medina-Mora, G. Borges, C. Lara, R. de Graaf, J. Ormel, O. Gureje, Y. Shen, Y. Huang, M. Zhang, J. Alonso, J.M. Haro, G. Vilagut, E.J. Bromet, S. Gluzman, C. Webb, R.C. Kessler, K.R. Merikangas, J.C. Anthony, M.R. Von Korff, P.S. Wang, T.S. Brugha, S. Aguilar-Gaxiola, S. Lee, S. Heeringa, B. Pennell, A.M. Zaslavsky, T.B. Ustun, S. Chatterji and WHO World Mental Health Survey Consortium. 2004. "Prevalence, Severity, and Unmet Need for Treatment of Mental Disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys." JAMA 291(21):2581-90. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15173149/).

Erskine, H.E., T.E. Moffitt, W.E. Copeland, E.J. Costello, A.J. Ferrari, G. Patton, L. Degenhardt, T. Vos, H.A. Whiteford and J.G. Scott. 2015. "A Heavy Burden on Young Minds: The Global Burden of Mental and Substance Use Disorders in Children and Youth." Psychol Med 45(7):1551-36. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25534496/).

Erskine, H.E., R.E. Norman, A. Ferrari, G.C.K. Chan, W.E. Copeland, H.A. Whiteford and J.G. Scott. 2016. "Long-Term Outcomes of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Conduct Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis." Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 55(10):841-50.

Erskine, H.E., S. Blondell, M. Enright, J. Shadid, Y. Wado, F.M. Wekesah, A.E. Wahdi, S.A. Wilopo, L.M. Vu, H.T.K. Dao, V.D. Nguyen, M.R. Emerson, S.L. Fine, Mengmeng Li, R.W. Blum, H.A. Whiteford and J.G. Scott. 2021. "Measuring the Prevalence of Mental Disorders in Adolescents in Kenya, Indonesia, and Vietnam: Study Protocol for the National Adolescent Mental Health Surveys." Journal of Adolescent Health. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X21002676).

Ferrari, A.J., F.J. Charlson, R.E. Norman, A.D. Flaxman, S.B. Patten, T. Vos and H.A. Whiteford. 2013. "The Epidemiological Modelling of Major Depressive Disorder: Application for the Global Burden of Disease Study 2010." PLOS One 8(7): e69637. (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0069637).

GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. 2022. "Global, Regional, and National Burden of 12 Mental Disorders in 204 Countries and Territories, 1990-2019: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019." 2(9):137-50. (https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00395-3/fulltext).

General Statistical Office. 2020. Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 / Completed Results of the 2019 Viet Nam Population and Housing Census. Hà Nội: NXB Thống kê.

Hafekost, J., D. Lawrence, K.B. de Haan, S.E. Johnson, S. Saw, W.J. Buckingham, M.G. Sawyer, J.A. and S.R. Zubrick. 2016. "Methodology of Young Minds Matter: The Second Australian Child and Adolescent Survey of Mental Health and Wellbeing." Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 50(9):866-75.

Hafstad, G.S. and E. Augusti. 2021. "A Lost Generation? Covid-19 and Adolescent Mental Health." The Lancet Psychiatry 8(8):640-41. (https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00179-6/fulltext).

Hoang M.D., T.T. Lam, A. Dao and B. Weiss. 2020. "Mental Health Literacy at the Public Health Level in Low and Middle Income Countries: An Exploratory Mixed Methods Study in Vietnam." PLOS One.

Hoang M.D., B. Weiss, T. Lam and H. Ho. 2018. "Mental Health Literacy and Intervention Program Adaptation in the Internationalization of School Psychology for Vietnam." Psychology in the School 55(8):941-54.

Hoàng Thế Hải and Bùi Thị Thanh Diệu. 2021. "Thái độ kỳ thị đối với người mắc bệnh tâm thần của học sinh trung học phổ thông /Stigma Attitudes Towards People with Mental Illness among High School Students." Tạp chí Khoa học và Công nghệ 19(2):33-37.

Jones E.A., A.K. Mitra and A.R. Bhuiyan. 2021. "Impact of Covid-19 on Mental Health in Adolescents: A Systematic Review." International Journal of Environmental Research and Public Health 18(5):2470. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33802278/).

Kamimura, A., H.N. Trinh, M. Johansen, J. Hurley, M. Pye, K. Sin and H. Nguyen. 2018. "Perceptions of Mental Health and Mental Health Services among College Students in Vietnam and the United States." Asian Journal of Psychiatry 37:15-19.

Keynejad, R.C., J. Spagnolo and G. Thornicroft. 2022. "Mental Healthcare in Primary and Community-Based Settings: Evidence Beyond the Who Mental Health Gap Action Programme (Mhgap) Intervention Guide." Evidence-Based Mental Health. (https://ebmh.bmj.com/content/early/2022/04/25/ebmental-2021-300401).

Kim, J.H.J., W. Tsai, T. Kodish, L.T. Trung, A.S. Lau and B. Weiss. 2019. "Cultural Variation in Temporal Associations among Somatic Complaints, Anxiety, and Depressive Symptoms in Adolescence." Journal of Psychosomatic Research 124:109763. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399919300030?via%3Dihub).

Mai D., N.N.K. Pham, S. Wallick and B.K. Nastasi. 2014. "Perceptions of Mental Illness and Related Stigma among Vietnamese Populations: Findings from a Mixed Method Study." Journal of Immigrant and Minority Health 16:1294-98.

Mckelvey, R.S., L.V. Baldassar, D.L. Sang and L. Roberts. 1999. "Vietnamese Parental Perceptions of Child and Adolescent Mental Illness." Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 38(10):1302-09. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10517064).

MOLISA (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). 2012. Quyết Định Số 1364/QĐ-LĐTBXH ngày 2 tháng 10 năm 2012 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012-2020 (Decision No. 1364/QD-LDTBXH dated October 2, 2012 Approving the Community-Based Planning of the Network of Social Protection Establishments Providing Care and Rehabilitation for Mentally Ill People and Mentally Disturbed People in the Period 2012-2020).

Nga L.L., I. Shochet, T. Tran, J. Fisher, A. Wurfl, N. Nguyen, J. Orr, R. Stocker and H. Nguyen. 2022. "Adaptation of a School-Based Mental Health Program for Adolescents in Vietnam." PLOS One 17(8): e0271959. (DOI: 10.1371/journal.pone.0271959).

Nguyen, T., T. Tran, H. Tran, T. Tran and J. Fisher. 2019. "Challenges in Integrating Mental Health into Primary Care in Vietnam." in Innovation in Global Mental Health, edited by S. Okpaku: Springer, Cham.

Nguyen, T.Q.C and T.H. Nguyen. 2018. "Mental Health Literacy: Knowledge of Depression among Undergraduate Students in Hanoi, Vietnam." International Journal of Mental Health Systems 24(12):19. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29760770/).

Ormel, J., A.M. Oerlemans, D. Raven, O.M. Laceulle, C.A. Hartman, R. Veenstra, F.C. Verhulst, W. Vollebergh, J.G.M. Rosmalen, S.A. Reijneveld, A.J. Oldehinkel. 2017. "Functional Outcomes of Child and Adolescent Mental Disorders. Current Disorder Most Important but Psychiatric History Matters as Well" Psychological Medicine 47(7):1271-82. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28065168/).

Pagliaro, C., M. Pearl, D. Lawrence, J.G. Scott and S. Diminic. 2021. "Estimating Demand for Mental Health Care among Australian Children and Adolescents: Findings from the Young Minds Matter Survey." Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 56(11):1443-54. (DOI: 10.1177/00048674211069874).

Patton G.C., S.M. Sawyer, J.S. Santelli, D.A. Ross, R. Afifi, N. Allen, M. Arora, P. Azzopardi, W. Baldwin, C. Bonell, R. Kakuma, E. Kennedy, J. Mahon, T. McGovern, A.H. Mokdad, V. Patel, S. Petroni, N. Reavley, K. Taiwo, J. Waldfogel, D. Wickremarathne, C. Barroso, Z. Bhutta, A.O. Fatusi, A. Mattoo, J. Diers, J. Fang, J. Ferguson, F. Ssewamala, R.M. Viner. 2016. "Our Future: A Lancet Commission on Adolescent Health and Wellbeing." The Lancet 387(10036): 2423-78.

Person, S., C. Hagquist and D. Michelson. 2017. "Young Voices in Mental Health Care: Exploring Children's and Adolescents' Service Experiences and Preferences." Clinical Child Psychology and Psychiatry 22(1):140-51. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27368712/).

Samuels, F., N. Jones, T. Gupta, B.T. Dang and D.H. Le. 2018. Mental Health and Psychosocial Wellbeing among Children and Young People in Selected Provinces and Cities in Viet Nam. Hanoi: UNICEF.

Schnyder, N., D. Lawrence, R. Panczak, M.G. Sawyer, H.A. Whiteford, P.M. Burgess and M.G. Harris. 2019. "Perceived need and barriers to adolescent mental health care: agreement between adolescents and their parents." Epidemiology and Psychiatric Sciences 29(e60). (DOI: https://doi.org/10.1017/S2045796019000568).

Shaffer, D., P. Fisher, C.P. Lucas, M.K. Dulcan and M.E.S. Stone. 2000. "Nimh Diagnostic Interview Schedule for Children Version Iv (Nimh Disc-Iv): Description, Differences from Previous Versions, and Reliability of Some Common Diagnoses." Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 39(1):28-38. (https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(09)66098-6/fulltext).

Thủ tướng Chính phủ. 2011. "Quyết Định Số 1215/QĐ-TTG ngày 22 tháng 7 năm 2011 phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020" (Decision No. 1215/QD-TTG dated July 22, 2011 Approving the Project on Social Assistance and Rehabilitation for the Mentally Ill and Mentally Disturbed People Based on the Community for the Period 2011-2020). Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ. 2020. "Quyết Định 1929/QĐ-TTG ngày 25 tháng 11 năm 2020 phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030." Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ. 2022. "Quyết Định 155/QĐ-TTG ngày 29 tháng 1 năm 2022 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025." Hà Nội.

Tran, T., H.T. Nguyen, I. Shochet, A. Wurfl, J. Orr, N. Nguyen, N. La, H. Nguyen, R. Stocker, T. Nguyen, M. Le and J. Fisher. 2020. "School-Based, Two-Arm, Parallel, Controlled Trial of a Culturally Adapted Resilience Intervention to Improve Adolescent Mental Health in Vietnam: Study Protocol." BMJ Open 10(10). (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7574926/).

Truc, T.T., N.L.L.T. Vu and H.H.T. Bui. 2020. "Mental Health Literacy and Help-Seeking Preferences in High School Students in Ho Chi Minh City, Vietnam" School Mental Health 12:378-87.

UNICEF. 2020a. "Rapid Assessment of Social and Economic Impacts of Covid-19 on Children and Families in Viet Nam." Ha Noi: UNICEF.

UNICEF. 2020b. "The Impact of Covid-19 on the Mental Health of Adolescents and Youth." Vol.

United Nations Children's Funds (UNICEF) and Overseas Development Institute (ODI). 2018. "The Nature of Suicide Amongst Children and Young People in Selected Provinces and Cities in Viet Nam." Hanoi: UNICEF. Retrieved. (https://www.unicef.org/vietnam/media/986/file/Suicide%20briefing.pdf).

Wasserman, D., H.T.T. Tran, D.T.M. Pham, M. Goldstein, A. Nordenskiöld and C. Wasserman. 2008. "Suicidal Process, Suicidal Communication and Psychosocial Situation of Young Suicide Attempters in a Rural Vietnamese Community." World Psychiatry 7(1):47-53. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2359725/pdf/wpa010047.pdf).

Weiss, B., M. Dang, L. Trung, M.C. Nguyen, H.T.T. Nguyen and A. Pollack. 2014. "A Nationally-Representative Epidemiological and Risk Factor Assessment of Child Mental Health in Vietnam." International Perspectives in Psychology 3(3):139-53.

World Health Organization. 2014. "Health for the World's Adolescents: A Second Chance in the Second Decade." Geneva. Retrieved. (https://apps.who.int/adolescent/second-decade/).

World Health Organization. 2016. Mhgap Intervention Guide for Mental, Neurological and Substance Use Disorders in Non-Specialized Health Settings: Mental Health Gap Action Programme (Mhgap) – Version 2.0. Geneva.

World Health Organization, Ministry of Health and Ministry of Education and Training. 2022. The 2019 Global School-Based Student Health Survey in Viet Nam: Report. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

*Khảo sát Sức khỏe Tâm thần Vị thành niên Việt Nam (V-NAMHS) -- Báo cáo các Phát hiện Chính*